Salud

Instituto Nacional de Salud

BES

Boletín Epidemiológico Semanal

Año 21



Comportamiento epidemiológico de dengue y enfermedad por virus Zika

Durante 2026, el seguimiento epidemiológico del dengue evidencia una reducción del 27,0 % en la notificación de casos en comparación con 2025.

Semana epidemiológica 33

16 al 22 de agosto de 2026

BES

Boletín Epidemiológico Semanal

El Boletín Epidemiológico Semanal (BES) es una publicación de tipo informativo que presenta el comportamiento de los principales eventos de interés en salud pública, que son vigilados por el Instituto Nacional de Salud (INS), presentando los casos notificados por las instituciones de salud, entidades territoriales y distritos. Tiene en cuenta los acumulados semanales y los promedios históricos.

Las cifras que publica el BES de casos y de muertes están siempre sujetas a verificación o estudio.

El BES es un insumo útil para la comprensión de los eventos en salud pública, brotes, tablas de mando por departamento, pero debe complementarse con otras fuentes. El INS dispone para consulta abierta del BES, los informes de evento y el Portal Sivigila.

***Los datos de Sivigila tienen procesos de ajuste por rezagos en la notificación**

109 AÑOS INS

Construyendo salud pública con y desde los territorios

Pág.

Tema central 3
Comportamiento epidemiológico de dengue, zika

Situación nacional 10

Mortalidad 12

Eventos trazadores 20

Brotes y alertas 39

Tablas de mando por departamento 43

TEMA CENTRAL

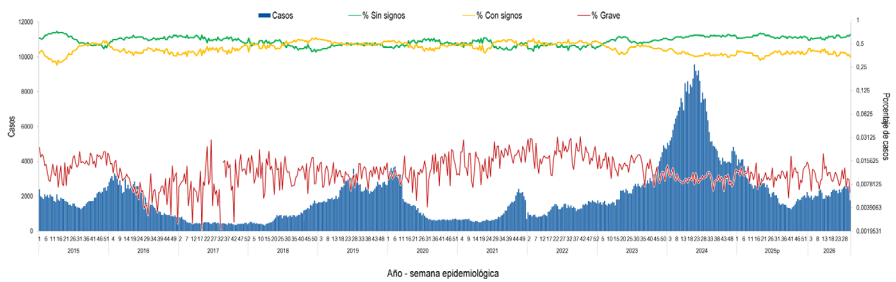
Comportamiento epidemiológico de dengue y enfermedad por virus Zika

Andrea Jineth Rodríguez Reyes, arodriguezr@ins.gov.co
Adriana Díaz Bello, abello@ins.gov.co
Lissethe Carolina Pardo Herrera, lpardo@ins.gov.co
José Leonardo Gómez Gómez, jgomezg@ins.gov.co

El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de mosquitos infectados principalmente de la especie *Aedes aegypti*, esta enfermedad es causada por el virus dengue (DENV) el cual pertenece al género Flavivirus, familia *Flaviviridae*, y del que se han identificado cuatro serotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4) (1,2). Se reconoce un espectro de manifestaciones de la enfermedad que van desde procesos asintomáticos hasta cuadros severos y, desde 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica el dengue según la complejidad del caso en dengue sin signos de alarma (grupo A), dengue con signos de alarma (grupo B), y dengue grave (grupo C); donde se encuentra incluido el síndrome de choque por dengue (SCD) y otras complicaciones, tales como: miocarditis, encefalitis y hepatitis que han sido asociadas a letalidad por dengue grave (3–7).

El Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) realiza de forma rutinaria un monitoreo de los eventos por arbovirus como dengue, chikunguña, enfermedad por virus Zika, fiebre amarilla, entre otros. De este grupo, el evento con la mayor incidencia estimada en Colombia es dengue, condición dada por las características geográficas del país, la identificación de diferentes serotipos del virus y la presencia del vector en la mayoría de los municipios (8). Desde el 2007, se observa un comportamiento fluctuante de dengue presentando las tasas de incidencia más altas en los ciclos epidémicos 2010, 2013, 2016, 2019 y 2024 (figura 1).

Figura 1. Comportamiento epidemiológico de dengue en Colombia, 2015–2026p



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Colombia, Sivigila, 2015 – 2026p.
p: datos preliminares

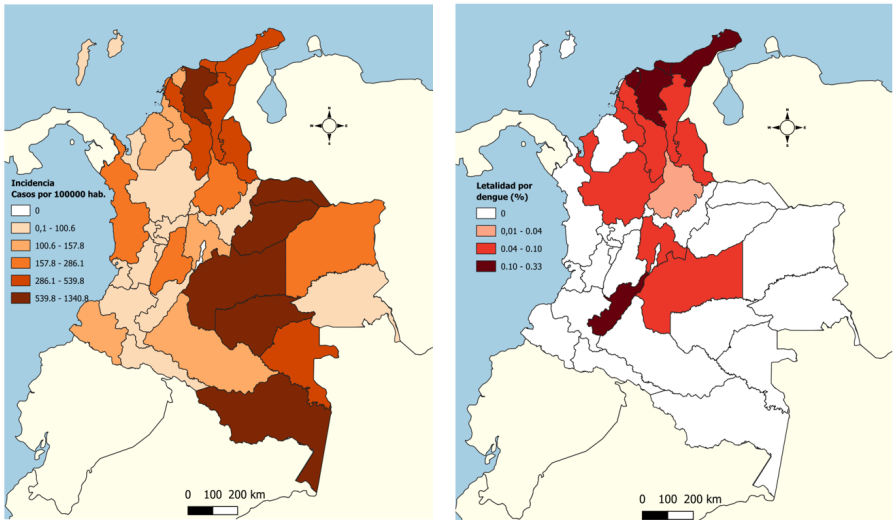
A periodo epidemiológico VIII del 2026, se notificaron 70 350 casos de dengue, 42 465 (60,4 %) sin signos de alarma, 27 183 (38,6 %) con signos de alarma y 702 (1,0 %) de dengue grave. La incidencia de dengue a nivel nacional es de 210,8 casos por cada 100 000 habitantes en riesgo. Las entidades territoriales

de Meta, Amazonas, Guaviare, Magdalena, Casanare, Arauca y Bolívar presentan las mayores incidencias, registrando tasas superiores a 530 casos por 100 000 habitantes (figura 2). A nivel nacional, se observa un descenso del 27,0 % en la notificación de casos con respecto al mismo periodo del 2025, donde se habían notificado 96 391 casos.

En cuanto a la letalidad por dengue, a periodo epidemiológico VIII de 2026, esta se encuentra en 0,06 %, con la confirmación de 41 muertes procedentes de Colombia y notificadas a Sivigila, indicador que es inferior a la meta establecida a nivel nacional en el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2022- 2031: < 0,10 %. Para el mismo periodo del 2025, se confirmaron 83 muertes por dengue procedentes de Colombia (letalidad por dengue: 0,09 %). Por otro lado, las entidades territoriales que registran las mayores letalidades superiores a 0,10 % son: La Guajira, Huila, Atlántico y Magdalena (figura 2).

Figura 2. Incidencia y letalidad por dengue por entidad territorial, a periodo epidemiológico VIII de 2026p

Incidencia de dengue **Letalidad por dengue**



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026p.
p: datos preliminares

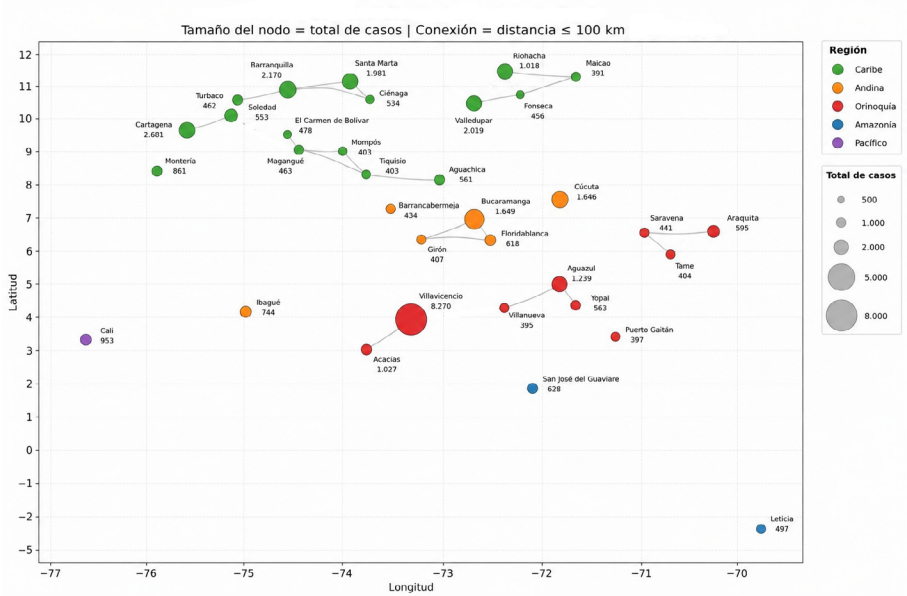
En el último periodo analizado (semanas epidemiológicas 28 a 31 de 2026) con respecto al periodo anterior (semanas epidemiológicas 24 a 27 de 2026), se observó una tendencia al aumento superior al 30,0 % en Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Barranquilla, Caldas, Cauca, Guaviare, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima y Vaupés; una tendencia al descenso mayor a 30,0 % en las entidades territoriales de Caquetá, La Guajira, Santa Marta y Vichada, mientras que las demás entidades territoriales presentaron un comportamiento estable.

A periodo epidemiológico VIII del 2026, el evento a nivel nacional según el canal endémico se ubica en brote, comparado con su comportamiento histórico, observándose una tendencia estable con una variación de 8,3 % en el último periodo analizado (semanas epidemiológicas 28 a 31 de 2026) con respecto al periodo anterior (semanas epidemiológicas 24 a 27 de 2026). Por entidad territorial, Amazonas, Arauca, Atlántico, Bolívar, Barranquilla, Cesar, Casanare, Meta, Guaviare, Quindío, Magdalena, Norte de Santander, Santa Marta, Archipiélago de San Andrés y Providencia y Vaupés se encuentran en situación de brote epidemiológico.

A periodo epidemiológico VIII de 2026, el 53,0 % (36 997) de los casos de dengue se concentra en 35 municipios, la red de proximidad geográfica de estos municipios evidencia la presencia de tres conglomerados territoriales principales: la región de la Orinoquia, la región Caribe y el corredor andino oriental. La Orinoquía se consolida como el principal foco epidemiológico del país, liderado por Villavicencio con 8 270 casos, municipio que además ocupa una posición estratégica por su cercanía y conexión con otros municipios de alta notificación como Acacías, Villanueva, Aguazul y Yopal. En la región Caribe se observa la red de mayor conectividad, con un corredor continuo entre Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Riohacha y municipios intermedios, reflejando condiciones de movilidad y proximidad geográfica que podrían facilitar la dispersión regional del dengue. Por su parte, la región Andina presenta un núcleo importante alrededor del área metropolitana de Bucaramanga, complementado por el comportamiento de Cúcuta como un foco de alta carga de enfermedad. En contraste, municipios como Santiago de Cali, San José del Guaviare y Leticia muestran una menor conectividad dentro de la red, sugiriendo dinámicas de transmisión más localizadas (figura 3).

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Figura 3. Red de proximidad geográfica entre municipios con la mayor notificación de casos de dengue, a periodo epidemiológica VIII, 2026p



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Colombia, Sivigila, 2026p.
p: datos preliminares

Con respecto a las variables sociales y demográficas, la mayor proporción de casos de dengue a periodo epidemiológico VIII de 2026 se presentó en hombres (52,2 %), en los grupos de edad de 0 a 19 años (49,2 %), en otros grupos poblacionales (94,1 %), régimen en salud subsidiado (59,2 %), y estratos socioeconómicos 1 Bajo-Bajo (57,8 %) y 2 bajo (27,9 %). Al analizar las muertes confirmadas hasta el momento, se observa que la mayor proporción de fallecimientos se han presentado en hombres (53,7 %) en los grupos de edad de 0 a 19 años (73,1 %), otros grupos poblacionales (90,2 %), régimen en salud subsidiado (63,4 %) y estrato socioeconómico 1 Bajo-Bajo (73,2 %).

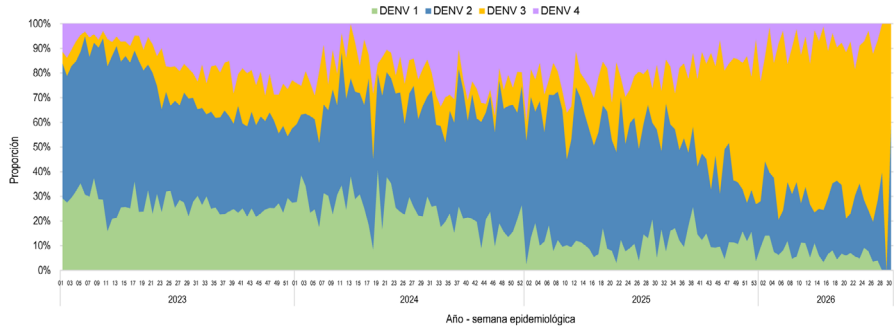
Por otro lado, los grupos de edad de 5 a 9 años y 10 a 17 años presentan las mayores incidencias de dengue a nivel nacional con 499,7 y 487,1 casos por 100 000 habitantes respectivamente, mientras que la mayor tasa de mortalidad se observó en el grupo 5 a 9 años (0,47 muertes por 100 000 habitantes) y la mayor letalidad en el grupo mayor de 65 años y más (0,11 %) y 5 a 9 años (0,09 %).

Para ampliar la información sobre el comportamiento epidemiológico del evento puede consultar el tablero de control de dengue dispuesto en el siguiente enlace: *http://url.ins. gov.co/-2i6o*

De acuerdo con la información reportada por el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) de Virología, durante el 2023-2026, datos preliminares, se mantiene la circulación de los cuatro serotipos del virus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4) a nivel nacional, sin embargo, se observa un aumento marcado en la proporción del serotipo 3 desde el cuarto trimestre de 2025 a la fecha, siendo este el más dominante (figura 3). Por otor lado, a nivel territorial se ha identificado la circulación de los cuatro serotipos en: Atlántico, Barranquilla, Bolívar, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Santander, Santa Marta, Sucre y Tolima, por el contrario, en Buenaventura, Guainía, Quindío, y Archipiélago de San Andrés y Providencia, no se ha identificado algún serotipo del virus en las muestras enviadas, mientras que en las demás entidades territoriales se han identificado tres serotipos o menos (figura 4).

Según la diversidad genética del virus, en los serotipos DENV -1, -3 y -4 se mantiene la circulación de un solo genotipo, los cuales son genotipo V, genotipo III y genotipo II respectivamente; mientras que en el serotipo DENV-2 se ha identificado el genotipo asiático-americano y Cosmopolitan.

Figura 4. Circulación de los serotipos del virus del dengue. Colombia, 2023 - 2026p



Fuente: LNR Virología, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2023-2026p.
p: datos preliminares

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Tablero de problemas de las unidades de análisis de las muertes por dengue, Colombia, a trimestre II de 2026

Durante el segundo trimestre de 2026, diez entidades territoriales realizaron tableros de problemas asociados a casos de mortalidad por dengue. La mayor concentración de hallazgos se registró en La Guajira, seguida de Magdalena y Meta. En conjunto, se identificaron 268 factores, características y situaciones problema relacionadas con el individuo y los servicios de salud.

En la categoría de servicios de salud se identificaron 136 características, de las cuales el 75,7 % se concentró en la prestación de servicios individuales, evidenciando debilidades en la calidad y oportunidad de la atención. Dentro de este factor se destacaron el incumplimiento de las guías de prácticas clínicas, el tratamiento inoportuno o inadecuado, el diagnóstico tardío y las deficiencias en el registro de la información en la historia clínica.

En la categoría de individuo se identificaron 132 características. El factor más frecuente correspondió a los conocimientos, actitudes y prácticas en salud (47, 7 %), destacándose la baja percepción del riesgo para consultar oportunamente a los servicios de salud, el desconocimiento de los signos y síntomas de alarma y la demora en la toma de decisiones para buscar atención médica.

El análisis de los tableros de problemas asociados a mortalidad por dengue evidencia que el evento responde a una interacción compleja de determinantes individuales, sociales y del sistema de salud, lo que refuerza su carácter multicausal y prevenible. En conjunto, los resultados muestran que la mayor carga de problemas se concentra en la atención en salud individual, seguida de debilidades en prevención y en la organización del sistema de salud.

A nivel nacional, los indicadores de unidades de análisis del evento mostraron un desempeño favorable durante el segundo trimestre de 2026, con cumplimientos superiores al 90,0 % en todos los indicadores evaluados y una correspondencia del 100,0 % entre los casos confirmados y los tableros de problemas. No obstante, persisten oportunidades de mejora en la oportunidad del cargue de las unidades de análisis, aspecto que requiere fortalecimiento para garantizar la disponibilidad oportuna de la información.

Conclusiones

A periodo epidemiológico VIII de 2026, a nivel nacional se observa un descenso significativo de la notificación de casos de dengue con respecto al mismo periodo del año 2025, sin embargo, el evento según el canal endémico se encuentra en situación de brote desde la semana epidemiológica 24 de 2026.

De las 15 entidades territoriales clasificadas en situación de brote, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Barranquilla, Guaviare, Norte de Santander, Sucre y Vaupés registran un incremento significativo en el último periodo epidemiológico analizado (semanas epidemiológicas 28 a 31 de 2026). Asimismo, Caldas, Huila, Putumayo y Tolima, que actualmente se encuentran en situación de alerta, presentan un incremento significativo.

Por entidad territorial, las incidencias más altas se presentan en Meta, Amazonas, Guaviare, Magdalena, Casanare, Arauca y Bolívar, mientras que las entidades con letalidades superiores a 0,10 % son La Guajira, Huila, Atlántico y Magdalena.

Las tasas de incidencia más altas se observaron en los menores de 17 años, mientras que las tasas de letalidad por dengue más altas se observaron en el grupo mayor de 65 años, seguido por el grupo de 5 a 9 años.

El 7,1 % de los municipios que notificaron casos en el último periodo concentran el 42,0 % (4 345) de los casos, identificándose incremento significativo en los siguientes municipios: San José del Guaviare, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Rosa del Sur, Ibagué, Aguachica, Mompós, Soledad, Tame y Ocaña.
En relación con la vigilancia virológica, se evidencia un aumento en la proporción del serotipo DENV -3 desde el cuarto trimestre de 2025 a la fecha.

De acuerdo con el análisis de problemas realizado por las entidades territoriales, durante el 2026 el mayor número de situaciones problema identificadas estuvieron relacionadas con los servicios de salud y características del individuo.

Recomendaciones

Dirigidas a las entidades territoriales, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) según su nivel de competencia:

- Fortalecer las acciones de vigilancia en salud pública del evento desde el nivel local, siguiendo con lo establecido en el protocolo de vigilancia en salud pública (9) y las directrices dadas desde el nivel nacional a través de las diferentes circulares vigentes (10); analizando además de la tendencia del

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

evento, los indicadores de gestión y predictores tempranos de gravedad de la enfermedad, (proporción de dengue con signos de alarma, dengue grave, entre otros indicadores) y difundirlos con los demás integrantes del grupo funcional, con el fin de evitar casos fatales por la enfermedad.

- Mantener una vigilancia activa del evento, mediante la realización de búsquedas activas institucionales y comunitarias, en situaciones de silencio epidemiológico o comportamientos inusuales.
- Mantener la vigilancia virológica del evento recolectando muestras biológicas en fase aguda según las directrices emitidas por el LNR de virología, con el fin de correlacionar estos resultados con el análisis epidemiológico, así como para orientar las actividades de control, promoción, prevención y vigilancia, enfocadas especialmente a la atención clínica de los casos e identificación oportuna de brotes.
- Implementar Salas de Análisis del Riesgo (SAR) a nivel territorial en situaciones de brote o en las que se amerite el análisis y la orientación para la toma de decisiones, articulando acciones con los diferentes actores del grupo funcional.
- Focalizar las acciones a nivel territorial analizando conjuntamente la información epidemiológica, virológica y entomológica, que permitan mejorar el manejo integral de los casos y las acciones de promoción, prevención y control, según las orientaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Considerando la potencial distribución de Aedes aegypti, se requiere mantener actualizada la información entomológica (levantamiento de índices aédicos) y el reporte de la categorización de niveles de riesgo entomológico por localidad.
- Realizar análisis de efectividad de las acciones de control implementadas y actualizar los registros de estas acciones.
- Dar continuidad a las acciones de evaluación de intervenciones de control, las cuales permiten detectar oportunamente localidades con potenciales poblaciones resistentes a los productos empleados.

Referencias

1. Khetarpal N, Khanna I. Dengue Fever: Causes, Complications, and Vaccine Strategies. J Immunol Res [Internet]. 2016 [citado el 24 de agosto de 2026];2016:6803098. Disponible en: *http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27525287*
2. Andraud M, Hens N, Marais C, Beutels P. Dynamic epidemiological models for dengue transmission: a systematic review of structural approaches. PLoS One [Internet]. 2012 [citado el 24 de agosto de 2026];7(11):e49085. Disponible en: *http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23139836*
3. World Health Organization. Dengue Guidelines For Diagnosis, Treatment, Prevention And Control Treatment, Prevention And Control Treatment, Prevention And Control [Internet]. 2009 [citado el 24 de agosto de 2026]. Disponible en: *www.who.int/tdr*
4. Li GH, Ning ZJ, Liu YM, Li XH. Neurological manifestations of dengue infection. Front Cell Infect Microbiol [Internet]. 2017 [citado el 24 de agosto de 2026];7(OCT):449. Disponible en: *http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29119088*
5. Li Y, Hu Z, Huang Y, Li J, Hong W, Qin Z, et al. Characterization of the Myocarditis during the worst outbreak of dengue infection in China. Medicine (Baltimore) [Internet]. julio de 2016 [citado el 24 de agosto de 2026];95(27):e4051. Disponible en: *http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27399087*
6. Castellanos J, Bello J, Velandia-Romero M. Manifestaciones neurológicas durante la infección por el virus del dengue. Infectio [Internet]. el 1 de octubre de 2014 [citado el 24 de agosto de 2026];18(4):167–76. Disponible en: *https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123939214000101*
7. Pereda MG, López M, Mariluz M. Dengue complicado y miocarditis: comunicación de un caso. Rev Chil infectología [Internet]. abril de 2015 [citado el 24 de agosto de 2026];32(2):238–9. Disponible en: *http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716- 10182015000300016&lng=en&nrm=iso&tlng=en*
8. Instituto Nacional de Salud. Publicaciones Informe de Evento [Internet]. [citado el 24 de agosto de 2026]. Disponible en: *https://www.ins.gov.co/ buscador-eventos/Paginas/Info-Evento.aspx*
9. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de dengue [Internet]. [citado el 24 de agosto de 2026]. Disponible en: *https:// www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Info-Evento.aspx*
10. Ministerio de Salud y Protección Social MSPS. Circular Conjunta Externa No.13 de 2023 [Internet]. Citado el 24 de agosto de 2026. Disponible en: *https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Conjunta%20Externa%20No.13%20de%202023.pdf*.

Enfermedad por virus Zika

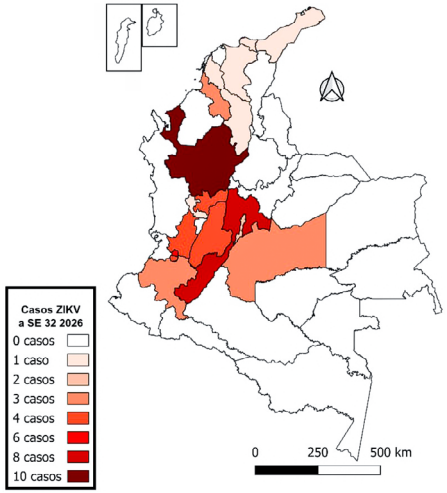
El virus del Zika (ZIKV) es un virus emergente de la familia Flaviviridae, transmitido por la picadura de hembras de mosquitos del género Aedes (1). En la mayoría de los casos, la infección en humanos es asintomática; sin embargo, pueden presentarse cuadros clínicos leves caracterizados por exantema maculopapular pruriginoso, cefalea, conjuntivitis, fiebre inferior a 38,5 °C y, en casos esporádicos, compromiso articular. Los síntomas suelen durar entre 5 y 7 días y son autolimitados (2). El virus también puede transmitirse por otros mecanismos, entre ellos la transmisión vertical transplacentaria de madre a hijo, el contacto sexual y la transmisión a través de transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos (3). En algunos casos, pueden presentarse complicaciones neurológicas, siendo la más importante el Síndrome de Guillain-Barré. De igual manera revisten gran importancia los trastornos del desarrollo del sistema nervioso central en el feto, en particular la microcefalia congénita, cuando la infección ocurre durante la gestación (4).

En Colombia, se la notificación ha disminuido progresivamente posterior al gran brote que se presentó en 2015-2026. Con corte a semana epidemiológica 32 de 2026, se tienen notificados 60 casos sospechosos para el evento, para una incidencia nacional de 0,18 por cada 100 000 habitantes en riesgo. De esos casos, 10 corresponden a gestantes y 13 a casos de síndrome neurológico. Es importante reiterar que ninguno de estos casos tiene confirmación por laboratorio.

Los 60 casos se concentran en 16 entidades territoriales, presentándose la mayoría en: Antioquia (10 casos, 16,7 %), Cundinamarca (8 casos, 13,3 %), Huila (8 casos, 13,3 %) y Santiago de Cali (6 casos, 10,0 %). Las mayores incidencias por 100 000 habitantes en riesgo están en: Cundinamarca (1,05), Caldas (0,92), Huila (0,88) y Sucre (0,38) (figura 5).

Figura 5. Comportamiento notificación enfermedad por virus Zika en Colombia, a semana epidemiológica 32 de 2026

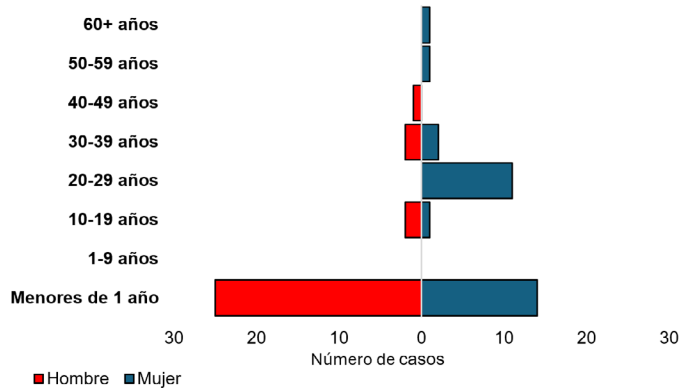
Comportamiento en Colombia 2026 (a SE 32)			
Entidad territorial	Casos	Proporción de casos	Incidencia*100000 hab
Antioquia	10	16,7 %	0,19
Cundinamarca	8	13,3 %	,05
Huila	8	13,3 %	0,88
Santiago de Cali	6	10,0 %	0,26
Caldas	4	6,7 %	0,92
Tolima	4	6,7 %	0,33
Valle del Cauca	4	6,7 %	0,24
Sucre	3	5,0 %	0,38
Meta	3	5,0 %	0,35
Cauca	3	5,0 %	0,32
Bogotá, D.C.	2	3,3 %	NA
Magdalena	1	1,7 %	0,19
Santa Marta	1	1,7 %	0,18
La Guajira	1	1,7 %	0,14
Risaralda	1	1,7 %	0,11
Bolívar	1	1,7 %	0,09



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Colombia, Sivigila 4.0., a semana epidemiológica 32 de 2026
SE: semana epidemiológica

La distribución entre hombres y mujeres es 50,0 % para cada uno. El 83,0 % de los casos procede de zona urbana. El 51,7 % tiene afiliación a régimen subsidiado y el 45,0 %, a contributivo. El 65,0 % corresponde a menores de un año (figura 2).

Figura 6. Casos sospechosos de enfermedad por virus Zika por sexo y grupo etario, Colombia, a semana epidemiológica 32 de 2026



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Colombia, Sivigila 4.0., a semana epidemiológica 32 de 2026

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

En cuanto a las manifestaciones clínicas, es llamativo que solo cuatro (4) de los 60 casos tienen reporte de exantema, que es el signo cardinal de la definición de caso sospechoso. También se registran 13 casos con fiebre y 13 con reporte de síndrome neurológico.

Al realizar el cruce de información entre enfermedad por virus Zika y defectos congénitos del sistema nervioso central, de los 284 registros de la base cruda inicial, se obtiene resultado de 160 casos, de los cuales 107 corresponden a microcefalia. De estos, el 77,6 % ya han sido descartados (por laboratorio o por no cumplimiento de definición de caso) para virus Zika y 24 se mantienen en la base como sospechosos, a la espera de actualización de información.

Conclusiones

- Desde el gran brote de ZIKV en Colombia (2015-2016), se presenta una disminución progresiva en la notificación de casos.
- No se cuenta con casos confirmados por laboratorio para ZIKV (desde 2020).
- Los reportes se dan principalmente en entidades de la región Andina.
- El 65,0 % de los reportes corresponde a menores de 1 año.

Recomendaciones

Equipos de vigilancia de todos los niveles:

- Verificar definiciones de caso para realizar la notificación, teniendo en cuenta criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio.
- Revisión y retroalimentación de la calidad del dato.
- Realizar cruces periódicos entre bases de ZIKV y defectos congénitos (enfatizando en sistema nervioso central) a modo de búsqueda activa y realizar seguimiento. A su vez, fortalecer búsquedas activas institucionales.
- Enfatizar seguimiento a notificación en grupos de riesgo (gestantes, menores de 1 año y adultos mayores).

EAPB y equipos asistenciales:

- Priorizar el seguimiento de gestantes con diagnóstico prenatal de defectos congénitos residentes en municipios con riesgo para arbovirosis.

Referencias

1. de Jong HK, Grobusch MP. Zika virus: an overview update. Curr Opin HIV AIDS. 2025 May 1;20(3):294-302. doi: 10.1097/COH.0000000000000926. Epub 2025 Mar 17. PMID: 40048580; PMCID: PMC11970592
2. Santana LMB, de Moura IA, Mouzinho Ramos Tanaka Y, França RFO. Zika Virus: A Review of Biology, Clinical Impacts, and Coinfections. Viruses. 2025 Apr 28;17(5):637. doi: 10.3390/v17050637. PMID: 40431649; PMCID: PMC12115944.
3. Tajik S, Farahani AV, Ardekani OS, Seyedi S, Tayebi Z, Kami M, Aghaei F, Hosseini TM, Nia MMK, Soheili R, Letafati A. Zika virus tropism and pathogenesis: understanding clinical impacts and transmission dynamics. Virol J. 2024 Oct 29;21(1):271. doi: 10.1186/s12985-024-02547-z. PMID: 39472938; PMCID: PMC11523830.
4. Christie CDC, Lue AM, Melbourne-Chambers RH. Dengue, chikungunya and zika arbovirus infections in Caribbean children. Curr Opin Pediatr. 2023 Apr 1;35(2):155-165. doi: 10.1097/MOP.0000000000001229. Epub 2023 Feb 22. PMID: 36801979; PMCID: PMC10090388.

SITUACIÓN NACIONAL

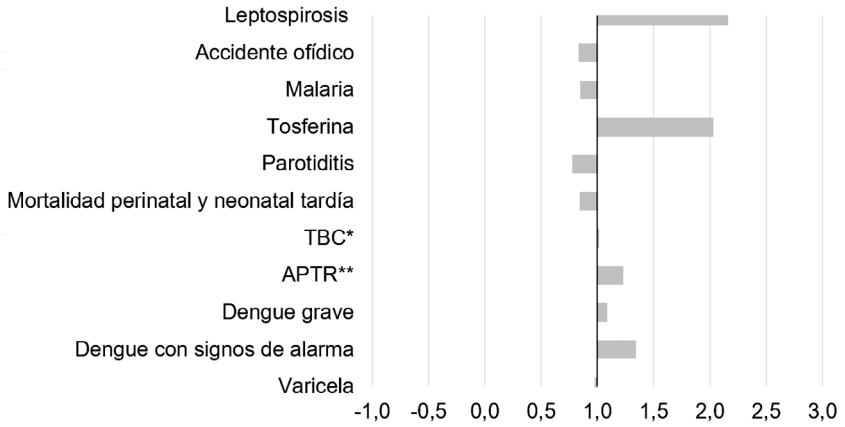
Tablero de control del análisis de datos de la vigilancia

Para el análisis de los eventos de mayor notificación en el país, se comparó el valor observado en la Semana Epidemiológica correspondiente, con una línea de base de referencia conformada por la información de esos eventos reportados en 15 intervalos de tiempo de al menos cinco años anteriores. Para el análisis de los eventos de dengue grave y dengue con signos de alarma, se excluye el año 2024, dado que corresponde a un periodo epidémico que podría sesgar los resultados.

Los datos son ajustados semanalmente por rezago en la notificación de los eventos de interés en salud pública.

Para la semana epidemiológica 33 de 2026, los eventos analizados a través de esta metodología se encontraron dentro del comportamiento histórico de la notificación (figura 7).

Figura 7. Comparación de la notificación de casos de eventos priorizados de alta frecuencia, según su comportamiento histórico. Colombia, semana epidemiológica 33 del 2026



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026
**TBC: tuberculosis*
***APTR: agresiones por animal potencialmente transmisor de rabia*

Para el evento de violencia de género e intrafamiliar de mayor notificación, se realiza el análisis utilizando la metodología de la prueba Z, en la que se comparó el valor observado en la semana epidemiológica evaluada con una línea de base conformada por los datos de los tres años anteriores (2023 a 2025), lo cual permite identificar variaciones significativas en la notificación de eventos de interés en salud pública.

Para esta semana, el evento violencia de género e intrafamiliar se encontró dentro del comportamiento histórico de la notificación (tabla 1).

Tabla 1. Comparación de casos notificados de violencia de género e intrafamiliar, según su comportamiento histórico. Colombia, semana epidemiológica 33 de 2026

Sección eventos última semana				
Evento	**Observado**	**Esperado**	**z**	**p**
Violencia de género e intrafamiliar	121.467	121.382	0,03	0,98

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026.

Para el análisis de los eventos de baja frecuencia o raros, en los cuales se asume ocurrencia aleatoria en el tiempo, se calculó la probabilidad de ocurrencia de cada evento según su comportamiento medio anterior, que para efectos de este análisis es el promedio de casos de 2021 a 2025. Con un nivel de confianza de p< 0,05 se determinó si existen diferencias significativas entre lo observado y lo esperado.

Los casos esperados se construyen con casos históricos que han sido confirmados, mientras que los casos observados corresponden a la notificación de la semana analizada exceptuando los casos descartados.

En la semana epidemiológica 33 del 2026, el evento de fiebre tifoidea y paratifoidea se encontró por encima de lo esperado, mientras que el evento leishmaniasis cutánea se encontró por debajo de lo esperado. El comportamiento de los demás eventos estuvo dentro de lo esperado (tabla 2).

Tabla 2. Comparación de casos notificados de eventos priorizados, de baja frecuencia, según el comportamiento histórico, Colombia, a semana epidemiológica 33 de 2026

Sección eventos última semana			
Evento	Observado	Esperado	p
Fiebre tifoidea y paratifoidea	3	1	0,04
Leishmaniasis cutánea	6	80	0,00
Leishmaniasis mucosa	0	1	0,37
Zika	2	2	0,27
Lepra	5	6	0,15
Mortalidad por dengue	5	4	0,14
Chicungunya	2	1	0,10

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026

Cumplimiento en la notificación

Corresponde al porcentaje semanal de la entrega del reporte de notificación en los días y horas establecidos para cada nivel del flujo de información en el Sivigila, sin exceptuar los festivos. Los objetivos de este indicador son:

- Identificar departamentos, municipios y Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) en silencio epidemiológico.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto 780 de 2016.
- Identificar entidades con bajo cumplimiento e implementar estrategias de seguimiento y mejoramiento.

A partir de la semana 17 de 2023 la medición del cumplimiento en la notificación para las entidades territoriales se realiza con la verificación de la red de operadores que se encuentra en Sivigila 4.0.

Para esta semana la notificación recibida por el Instituto Nacional de Salud correspondiente a las Unidades Notificadoras Departamentales y Distritales (UND) fue del 100 %, observando el mismo comportamiento respecto a la semana anterior y a la semana 33 del año 2025. Para esta semana, el país cumplió con la meta para este nivel de información.

El reporte de las Unidades Notificadoras Municipales (UNM) a nivel nacional fue del 100 % (1 123 de 1 123 UNM), observando un comportamiento igual con respecto a la semana anterior y a la semana epidemiológica 33 de 2025. El país cumplió con la meta establecida para este nivel de información que es como mínimo del 98 %.

El cumplimiento de las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) esta semana fue del 100 % (4 756 / 4 756), observando un aumento de 0,06 % con respecto a la semana anterior y permaneciendo igual con respecto a la semana 33 del año 2025. El país cumplió con la meta para la notificación establecida para UPGD.

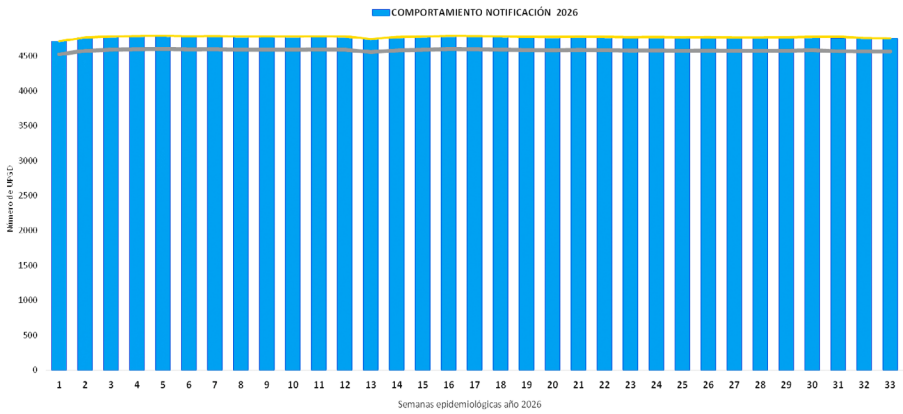
De manera complementaria, en el marco de la atención de la emergencia, se realizó el seguimiento a la caracterización de la red notificadora. En relación con la operación de las UPGD, el departamento del Valle del Cauca y el distrito de Buenaventura mantienen la totalidad de sus UPGD activas desde la ocurrencia del evento sísmico en la semana epidemiológica 31, garantizando la continuidad del proceso de notificación.

Por su parte, las entidades territoriales de Cali (8 UPGD inactivadas temporalmente), Caldas (1), Quindío (2), Risaralda (10) y Chocó (1) reportaron limitaciones operativas que afectaron la capacidad de algunas UPGD para realizar la notificación durante el periodo evaluado, por lo cual estas fueron inactivadas temporalmente.

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

A continuación, se presenta el comportamiento de la notificación por semana epidemiológica para el año 2026, incluyendo el número de UPGD caracterizadas y el cumplimiento de la meta de notificación en este nivel (96 %), establecido en 4 566 UPGD en la semana analizada (figura 8).

Figura 8. Cumplimiento de la notificación por UPGD, Colombia, semana epidemiológica 33 de 2026



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026.

MORTALIDAD

Mortalidad en menores de cinco años por eventos priorizados

Metodología

La definición operativa del evento es: menores de cinco años (entre 0 y 59 meses de edad) fallecidos y que tengan registrado en la cascada fisiopatológica del certificado de defunción (causas directas, relacionadas y otros estados patológicos) infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda o desnutrición aguda. Todos los casos ingresan a Sivigila como probables y deben clasificarse por medio de unidad de análisis[1].

Para el análisis de los datos se establecieron los comportamientos inusuales en cada entidad territorial en la semana epidemiológica analizada. Para esto, se comparó el número de casos observados acumulados en cada clase de mortalidad (infección respiratoria aguda, por desnutrición aguda y enfermedad diarreica aguda) con la mediana del periodo histórico correspondiente a la misma semana epidemiológica entre 2019 y 2025; se excluyeron los años 2020 y 2021 por pandemia COVID-19. Con la prueba de Poisson se comprobó la significancia estadística de la diferencia entre el valor observado y lo esperado con un valor de p<0,05, que identifica las entidades territoriales que presentaron aumentos o disminuciones estadísticamente significativas.

El cálculo de la tasa de mortalidad se realizó con casos confirmados, sin tener en cuenta los casos residentes del exterior. Como denominador se utilizó la proyección de la población del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas Vitales – DANE. Para el 2026 y 2025 la información es preliminar teniendo en cuenta la revisión, análisis y clasificación de los casos probables.

El acumulado de muertes notificadas para los tres (3) eventos puede variar por la notificación tardía y la clasificación final del caso en la unidad de análisis.

1. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda o desnutrición aguda. Versión 03. 05 de mayo de 2024. http://url.ins.gov.co/9130q

A la semana epidemiológica 33 del 2026, se han notificado 414 muertes probables en menores de cinco años, ocho (8) casos de infección respiratoria aguda (IRA), cuatro (4) de desnutrición aguda y uno (1) de enfermedad diarreica aguda (EDA) residían en el exterior, por lo cual no se incluyeron en el análisis.

De los 401 casos notificados de residentes en Colombia, 248 fueron por IRA, 83 por desnutrición (DNT) aguda y 70 por EDA. De estos casos, 179 fueron confirmados, 72 descartados y 150 se encuentran en estudio (tabla 3).

Tabla 3. Tasas de mortalidad y casos en menores de cinco años por IRA, EDA o DNT aguda según entidad territorial de residencia, Colombia, a semana epidemiológica 33 de 2026

Entidad territorial residencia	Casos confirmados a SE 33 2026			Casos en estudio a SE 33 2026			Tasa a SE 332026		
	DNT	IRA	EDA	DNT	IRA	EDA	DNT	IRA	EDA
Colombia	**46**	**96**	**37**	**30**	**99**	**21**	**1,26**	**2,64**	**1,02**
Amazonas	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00
Antioquia	4	10	1	3	13	2	0,96	2,39	0,24
Arauca	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	4,30
Atlántico	0	2	0	0	1	0	0,00	1,69	0,00
Barranquilla	1	4	1	0	1	0	1,24	4,95	1,24
Bogotá, D.C.	0	11	0	0	12	1	0,00	2,59	0,00
Bolívar	2	4	0	1	6	1	1,83	3,66	0,00
Boyacá	0	1	0	0	2	0	0,00	1,20	0,00
Buenaventura	0	0	0	2	2	2	0,00	0,00	0,00
Cali	0	1	0	1	0	0	0,00	0,89	0,00
Caquetá	0	1	0	0	0	0	0,00	2,54	0,00
Cartagena	0	2	0	0	4	0	0,00	2,68	0,00
Casanare	0	2	0	0	1	0	0,00	5,20	0,00
Cauca	0	1	1	2	3	1	0,00	0,82	0,82
Cesar	4	6	2	4	3	1	2,98	4,47	1,49
Chocó	13	13	8	6	14	1	20,09	20,09	12,36
Córdoba	1	6	0	0	3	1	0,59	3,55	0,00
Cundinamarca	0	2	0	0	4	0	0,00	0,88	0,00
Huila	0	2	1	0	0	0	0,00	1,89	0,95
La Guajira	13	7	7	4	10	4	11,65	6,27	6,27
Magdalena	0	2	3	2	1	1	0,00	2,23	3,34
Meta	2	4	0	0	2	1	2,35	4,69	0,00
Nariño	0	4	2	0	1	0	0,00	3,20	1,60
Norte de Santander	0	3	0	0	0	0	0,00	2,61	0,00
Putumayo	1	0	1	0	0	1	2,99	0,00	2,99
Quindío	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00
Risaralda	0	2	2	1	7	0	0,00	3,39	3,39
Santa Marta	1	0	1	0	0	0	2,30	0,00	2,30
Santander	0	2	1	0	1	0	0,00	1,33	0,66
Sucre	0	1	1	0	0	0	0,00	1,15	1,15
Tolima	0	2	1	1	2	1	0,00	2,19	1,09
Valle del Cauca	0	1	0	1	2	2	0,00	0,77	0,00
Vaupés	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	36,46
Vichada	4	0	1	2	2	1	23,54	0,00	5,89

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026 preliminares. SE: semana epidemiológica

Tasa de mortalidad: *se realiza con casos confirmados y la información es preliminar teniendo en cuenta la revisión de las unidades de análisis y la clasificación de los casos probables y no concluyentes; denominador: por 100 000 menores de cinco años.*

Nota: *las entidades territoriales que no registraron casos a SE 33 de 2026, no figuran en la tabla.*

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Mortalidad por infección respiratoria aguda

A semana epidemiológica 33 del 2026 se han notificado 248 muertes probables en menores de cinco años residentes de Colombia por IRA, 52 confirmadas por laboratorio, 44 confirmadas por clínica, 53 descartadas, y 99 se encuentran en estudio, para una tasa de mortalidad de 2,64 casos por cada 100 000 menores de cinco años. Para el 2025, el número de casos confirmados a semana epidemiológica 33 fueron 191, para una tasa de mortalidad de 5,18 casos por cada 100 000 menores de cinco años.

En comparación con el histórico correspondiente a la semana epidemiológica 33 del 2019 al 2025, se observaron diferencias estadísticamente significativas en el número de muertes probables por IRA notificadas en las entidades territoriales de Antioquia, Bolívar, Distrito de Cali, Caquetá, Cesar y La Guajira y, a nivel municipal, en Dabeiba, Valledupar y Riosucio. La información puede ser consultada en las **tablas de mando del BES**.

Los agentes etiológicos identificados en los casos confirmados a semana epidemiológica 33 de 2026 son Rhinovirus, *Bordetella pertussis*, y Enterovirus, entre otros (tabla 4).

Tabla 4. Agentes etiológicos identificados en las muertes notificadas en menores de cinco años por IRA según grupo de edad, Colombia, a semana epidemiológica 33, 2025–2026

Agente etiológico	2025						2026					
	Menor de un año	1 año	2 años	3 años	4 años	Total	Menor de un año	1 año	2 años	3 años	4 años	Total
Rhinovirus	10	2	6	1	0	19	9	3	1	2	2	17
Bordetella pertussis	8	0	0	0	0	8	14	1	0	0	0	15
Enterovirus	9	1	3	1	0	14	4	2	0	2	2	10
Streptococcus pneumoniae	4	2	2	1	0	9	4	2	1	1	2	10
Adenovirus	5	0	2	1	1	9	1	2	1	3	1	8
Haemophilus influenzae B	6	4	0	1	0	11	3	2	0	1	1	7
Staphylococcus aureus	7	1	1	0	0	9	5	1	1	0	0	7
Virus Sincitial Respiratorio	10	2	2	0	0	14	7	0	0	0	0	7
Metapneumovirus	2	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	5
Moraxella catarrhalis	3	3	1	0	0	7	2	1	0	0	1	4
Pseudomona aeruginosa	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	3
Parainfluenza tipo 1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2
Influenza A	5	0	2	1	0	8	0	0	0	0	1	1
Klebsiella pneumoniae	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1
Parainfluenza tipo 3	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1
SARS-CoV2	4	1	0	1	0	6	1	0	0	0	0	1
Escherichia coli	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Influenza B	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mycoplasma pneumoniae	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Parainfluenza tipo 4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Streptococcus pyogenes	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Total	81	20	20	7	1	129	56	15	7	10	11	99

Fuente: Unidades de análisis, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2025 – 2026 (datos preliminares).

Mortalidad por desnutrición aguda

A la semana epidemiológica 33 de 2026 se han notificado 83 muertes probables en menores de cinco años reside ntes en Colombia por DNT aguda, 46 confirmadas, siete (7) descartadas y 30 se encuentran en estudio, para una tasa de mortalidad de 1,26 casos por cada 100 000 menores de cinco años. Para el 2025, el número de casos confirmados a semana epidemiológica 33 fue de 113, para una tasa de mortalidad de 3,06 casos por cada 100 000 menores de cinco años.

En comparación con el histórico correspondiente a la semana epidemiológica 33 del 2019 al 2025, se observaron diferencias estadísticamente significativas en el número de muertes probables por DNT aguda notificadas en las entidades territoriales de Atlántico, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Santander y Risaralda, y en el nivel municipal en Bagadó, Medio Baudó, Riohacha, Maicao y Manaure. La información puede ser consultada en las **tablas de mando del BES**.

Mortalidad por enfermedad diarreica aguda

A la semana epidemiológica 33 de 2026 se han notificado 70 muertes probables en menores de cinco años por EDA residentes de Colombia, 35 confirmadas por clínica, dos (2) confirmadas por laboratorio, 12 descartadas y 21 se encuentran en estudio, para una tasa de mortalidad de 1,02 casos por cada 100 000 menores de cinco años. Para el 2025, el número de casos confirmados a semana epidemiológica 33 fue de 52 para una tasa de mortalidad de 1,41 casos por cada 100 000 menores de cinco años.

En comparación con el histórico correspondiente a la semana epidemiológica 33 del 2019 al 2025, se observaron diferencias estadísticamente significativas en el número de muertes probables por EDA aguda notificadas en la entidad territorial de Chocó, La Guajira, Magdalena y Risaralda, y a nivel municipal, en Bagadó y Uribia. La información puede ser consultada en las **tablas de mando del BES**.

Mortalidad materna

Metodología

De acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se acogen las siguientes definiciones[1]:

Muerte materna: es la muerte de una mujer que ocurre estando embarazada o dentro de los 42 días de haber terminado un embarazo, independientemente de la duración y la localización del embarazo, por cualquier causa vinculada o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales.

Muerte materna tardía: es la muerte de una mujer por causas directas o indirectas más de 42 días después pero antes de un año de haber terminado el embarazo.

Muerte materna por causas coincidentes: corresponde a las muertes por lesión de causa externa.

En el país se realiza la vigilancia de la muerte materna que incluye la muerte durante el embarazo y hasta 42 días, muerte materna tardía y muerte materna por causas coincidentes. La muerte materna ocurrida durante el embarazo y hasta los 42 días de su terminación es denominada muerte materna temprana[2].

Para el análisis del comportamiento inusual, por ser la mortalidad materna un evento de baja frecuencia, se usó la distribución de probabilidades de Poisson por medio de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento según su comportamiento medio entre el 2022 y 2025 con corte al periodo de tiempo por analizar.

La clasificación final de los casos puede variar de acuerdo con la dinámica propia de la vigilancia y la conclusión de las unidades de análisis.

1. Organización Mundial de la Salud. Guía de la OMS para la aplicación de la CIE-10 a las muertes ocurridas durante el embarazo, parto y puerperio: CIE MM https://www.binasss.sa.cr/guiaops.pdf

2. Colombia. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de vigilancia en salud pública de mortalidad materna. Versión 09; 2024. https://doi.org/10.33610/UFOZ8779

En la semana epidemiológica 33 de 2026 se notificaron al Sivigila siete (7) casos: dos (2) muertes maternas tempranas, cuatro (4) muertes maternas tardías y una (1) muerte materna coincidente. El país acumula 91 casos de muertes maternas tempranas, de las cuales 87 residen en territorio colombiano y cuatro (4) residen en el exterior, por lo que no se incluyen en el análisis (tabla 5).

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Tabla 5. Mortalidad materna según tipo de muerte, Colombia, a semana epidemiológica 33, 2023 a 2026

Año	Tipo de muerte			Total
	Temprana	Tardía	Coincidente	
2023	168	99	50	317
2024	133	90	32	255
2025	118	99	33	250
2026p	87	74	34	195

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2023-2025, datos preliminares 2026, p: datos preliminares

Se notificaron casos de muertes maternas tempranas en 26 entidades territoriales, con mayor número de casos en Antioquia, Bogotá D.C., La Guajira, Chocó, Cundinamarca y Magdalena. Al comparar con el promedio histórico 2022–2025, se observaron diferencias estadísticamente significativas a nivel nacional en Atlántico, Barranquilla, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander y Santander; sin diferencias estadísticamente significativas en las demás entidades territoriales (tabla 6).

Al realizar análisis desagregado por municipio, se presentó un caso de muerte materna temprana en Frontino (Antioquia), San Martín de Loba (Bolívar), Carmen del Darién (Chocó), Buenavista (Córdoba) y Santa Ana (Magdalena); en el promedio histórico 2022–2025, estos municipios no habían registrado casos para este evento (tabla 7).

En cuanto a la causa básica agrupada de las muertes maternas tempranas a semana epidemiológica 33 de 2026, el 55,2 % corresponde a causas directas y el 33,3 % a causas indirectas. La principal causa de muerte materna directa fue el trastorno hipertensivo asociado al embarazo con el 21,2 % (tabla 8).

Tabla 6. Mortalidad materna temprana según entidad territorial de residencia, Colombia, a semana epidemiológica 33 de 2025 y 2026

Entidad territorial de residencia	Promedio histórico 2022-2025 a SE 33	Acumulado de casos a SE 33	
		2025	2026
Colombia	**146**	**118**	**87**
Antioquia	14	13	11
Bogotá, D.C.	12	10	11
La Guajira	12	9	7
Chocó	8	5	6
Cundinamarca	7	5	5
Magdalena	5	2	5
Cartagena de Indias	4	1	4
Cesar	8	11	4
Nariño	7	5	4
Caquetá	2	1	3
Cauca	6	1	3
Risaralda	3	3	3
Tolima	4	3	3
Boyacá	3	2	2
Casanare	1	3	2
Huila	3	2	2
Quindío	1	1	2
Sucre	2	1	2
Bolívar	6	5	1
Buenaventura	2	1	1
Santiago de Cali	4	4	1
Córdoba	6	4	1
Meta	3	1	1
Santa Marta	3	2	1
Valle del Cauca	2	2	1
Vichada	2	1	1
Arauca	1	0	0
Atlántico	5	5	0
Barranquilla	4	4	0
Caldas	1	0	0
Guainía	1	2	0
Norte de Santander	5	6	0
Putumayo	1	0	0
Santander	3	3	0

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2025 – 2026 (datos preliminares).

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Tabla 7. Entidades territoriales con comportamiento inusual de mortalidad materna respecto al promedio 2022-2025, Colombia, semana epidemiológica 33 del 2026

Municipio de residencia	Promedio histórico 2022 – 2025 a SE 33	Valor observado SE 33
Colombia	146	87
Frontino (Antioquia)	0	1*
San Martín de Loba (Bolívar)	0	1*
Carmen del Darién (Chocó)	0	1*
Buenavista (Córdoba)	0	1*
Santa Ana (Magdalena)	0	1*

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2022-2025, datos preliminares 2026.
SE: Semana Epidemiológica.
**Municipios que en el promedio histórico 2022 – 2025 no presentaron muertes maternas tempranas*

Tabla 8. Mortalidad materna por tipo y causa agrupada, Colombia, a semana epidemiológica 33 del 2026

Causa agrupada	Promedio histórico 2024-2025 a SE 33	Número de casos y proporción a SE 33 2024-2026					
		2024	%	2025	%	2026	%
Colombia	**126**	**133**	**100**	**118**	**100**	**87**	**100**
DIRECTA	**80**	**85**	**63,9**	**74**	**62,7**	**48**	**55,2**
Trastorno hipertensivo asociado al embarazo	27	27	20,3	27	22,9	18	21,2
Hemorragia obstétrica	24	27	20,3	21	17,8	8	9,2
Evento tromboembólico como causa básica	7	7	5,3	7	5,9	8	9,2
Sepsis obstétrica	6	6	4,5	6	5,1	5	5,7
Embarazo ectópico	7	7	5,3	6	5,1	3	3,4
Embarazo terminado en aborto con causa directa: sepsis	5	4	3,0	5	4,2	3	3,4
Embolia de líquido amniótico	2	3	2,3	0	0,0	1	1,1
Embarazo terminado en aborto con causa directa: hemorragia	3	3	2,3	2	1,7	1	1,1
Embarazo terminado en aborto con causa directa: evento tromboembólico	0	0	0,0	0	0,0	1	1,1
Otras causas directas	1	1	0,8	0	0,0	0	0,0
INDIRECTA	**44**	**46**	**34,6**	**42**	**35,6**	**29**	**33,3**
Otras causas indirectas	17	18	13,5	15	12,7	17	19,5
Otras causas indirectas: neumonía	8	5	3,8	10	8,5	6	6,9
Sepsis no obstétrica	8	7	5,3	8	6,8	3	3,4
Otras causas indirectas: cáncer	6	8	6,0	4	3,4	3	3,4
Otras causas indirectas: malaria	2	0	0,0	3	2,5	0	0,0
Otras causas indirectas: tuberculosis	2	2	1,5	2	1,7	0	0,0
Otras causas indirectas: dengue	2	4	3,0	0	0,0	0	0,0
Otras causas indirectas: VIH-SIDA	1	1	0,8	0	0,0	0	0,0
Otras causas indirectas: neumonía por Covid 19	1	1	0,8	0	0,0	0	0,0
Desconocida / indeterminada	1	0	0,0	1	0,8	0	0,0
En estudio	**2**	**2**	**1,5**	**1**	**0,8**	**10**	**11,5**

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2024 - 2025, datos preliminares 2026.
SE: Semana Epidemiológica.

Mortalidad perinatal y neonatal tardía

Metodología

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la mortalidad perinatal y neonatal tardía como: muerte perinatal, correspondiente a la ocurrida en el periodo comprendido a partir de las 22 semanas completas de gestación o con 500 gramos o más de peso fetal, hasta los siete días después del nacimiento; muerte neonatal tardía que corresponde a la ocurrida después de los siete días hasta el día 28 de vida[1]. Se incluyeron en el análisis los casos residentes en el país.

El análisis del comportamiento inusual se realizó combinando dos metodologías; para las entidades territoriales con baja frecuencia (n <=30 acumulado a la semana de análisis) se utilizó el método de distribución de probabilidades de Poisson, y para los departamentos y distritos con alta frecuencia (n >30 acumulado a la semana de análisis) se adaptó el método *Morbidity and Mortality Weekly Report* (MMWR) del Center for Disease Control and Prevention (CDC). El periodo de comparación para las dos metodologías corresponde al promedio entre el 2021 y 2025 con corte al periodo de análisis y se muestran resultados estadísticamente significativos (p<0,05). El análisis de causas de muerte se realizó de acuerdo con la metodología de la OMS para agrupación de causas de muerte durante el periodo perinatal[2].

Los datos pueden variar semanalmente por la notificación tardía y ajuste de casos al Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

1. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de vigilancia de mortalidad perinatal y neonatal tardía. Versión 07. 25 de junio de 2024. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Mortalidad%20perinatal.pdf

2. Organización Mundial de la Salud. The WHO application of ICD-10 to deaths during the perinatal period: ICD-PM. 2016. Disponible en: https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/maternal-nb/icd-pm.pdf?Status=Master&sfvrsn=9470cccf_2#:~:text=ICD%2DPM%20is%20designed%20to,be%20classified%20using%20ICD%2DPM

A semana epidemiológica 33 del 2026 se han notificado 3 895 casos de muerte perinatal y neonatal tardía, de los cuales 3 857 corresponden a residentes en Colombia y 38 a residentes en el exterior.

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

El mayor número de casos se notificó en Antioquia, Bogotá, D.C., Cundinamarca, La Guajira y Córdoba. Teniendo en cuenta el promedio histórico de la notificación entre el 2021 y el 2025, con corte a semana epidemiológica 33 del 2026, se observaron diferencias estadísticamente significativas en Putumayo, Guaviare, San Andrés y Providencia (tabla 9).

En el análisis municipal se observaron variaciones de aumento significativas en el comportamiento histórico del evento en los siguientes municipios: Manaure (La Guajira), Cumaribo (Vichada), Dosquebradas (Risaralda), Tunja (Boyacá), Granada (Meta), La Estrella (Antioquia), Alto Baudó (Chocó), Isnos (Huila), Puerto López (Meta), Roberto Payán (Nariño), Guamo (Tolima), Peñol (Antioquia), Cicuco (Bolívar), Paipa (Boyacá), Bahía Solano (Chocó), Carmen del Darién (Chocó), Quimbaya (Quindío), Giraldo (Antioquia), Tolú Viejo (Sucre), Restrepo (Valle del Cauca), Cisneros (Antioquia), Tesalia (Huila), La Tola (Nariño), Paz de Río (Boyacá), Marulanda (Caldas), Jerusalén (Cundinamarca), Salento (Quindío) y Betulia (Santander) (tabla 10).

Según el momento de ocurrencia de la muerte, la mayor proporción corresponde a muertes perinatales anteparto con 42,5 %, seguido de neonatales tempranas con 27,9 %, neonatales tardías con 18,3 %, y las fetales intraparto con 11,4 %.

De acuerdo con las causas de muerte agrupadas, la mayor proporción se concentra en: asfixia y causas relacionadas con un 25,2 %, seguido de prematuridad e inmaturidad con el 17,9 % y complicaciones de la placenta, cordón y membranas con el 14,0 % (tabla 11). Se observó un incremento a corte de semana epidemiológica 33 del 2026 (datos preliminares) frente a 2025 en causas de muerte no específicas y sin información en causa básica de muerte; en consecuencia, se invita a las entidades territoriales que notifican a realizar la gestión necesaria para la correcta definición de la causa básica de muerte

Tabla 9. Número de casos y comportamientos inusuales en la notificación de mortalidad perinatal y neonatal tardía por entidad territorial de residencia, Colombia, a semana epidemiológica 33 del 2025 y 2026

Entidad territorial de residencia	Valor histórico 2021-2025 SE 33	Acumulado de casos a SE 33	
		2025	2026
Colombia	**4 750**	**3 566**	**3 857**
Antioquia	537	427	480
Bogotá, D.C.	498	405	480
Cundinamarca	263	234	228
La Guajira	250	169	173
Córdoba	240	153	168
Santiago de Cali	188	166	160
Cesar	171	137	145
Bolívar	141	102	133
Barranquilla	172	101	128
Cauca	155	102	127
Norte de Santander	145	102	111
Valle del Cauca	130	109	108
Santander	146	101	107
Huila	115	78	104
Nariño	130	132	103
Chocó	113	64	98
Cartagena de Indias	148	94	96
Sucre	119	68	91
Meta	116	110	90
Atlántico	142	82	81
Magdalena	122	93	73
Boyacá	89	72	70
Risaralda	67	50	68
Tolima	96	63	68
Caldas	63	55	54
Santa Marta	59	42	53
Quindío	38	30	38
Buenaventura	50	46	37
Arauca	40	17	35
Caquetá	42	28	33
Casanare	49	40	31
Vichada	24	23	27
Putumayo	39	24	22
Guainía	12	10	15
Amazonas	13	13	11
Vaupés	9	7	5
Guaviare	10	8	4
San Andrés y Providencia	8	9	2

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2021 - 2025, datos preliminares 2026.
SE: Semana Epidemiológica.

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Tabla 10. Municipios con comportamientos inusuales de la notificación de casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía, Colombia, a semana epidemiológica 33 del 2026

Municipio de residencia	Promedio histórico acumulado a SE 33 2021 - 2025	Valor observado a SE 33 de 2026	Semanas continuas en incremento
Colombia	**4750**	**3857**	**-**
Manaure (La Guajira)	22	29	16
Cumaribo (Vichada)	15	23	15
Dosquebradas (Risaralda)	14	21	24
Tunja (Boyacá)	11	18	30
Granada (Meta)	8	15	31
La Estrella (Antioquia)	4	11	18
Alto Baudó (Chocó)	3	10	20
Isnos (Huila)	3	6	13
Puerto López (Meta)	2	6	7
Roberto Payán (Nariño)	2	6	25
Guamo (Tolima)	2	6	9
Peñol (Antioquia)	2	5	16
Cicuco (Bolívar)	2	5	9
Paipa (Boyacá)	2	5	16
Bahía Solano (Chocó)	1	5	22
Carmen del Darién (Chocó)	2	5	7
Quimbaya (Quindío)	2	5	9
Giraldo (Antioquia)	1	4	9
Tolú Viejo (Sucre)	1	4	13
Restrepo (Valle del Cauca)	1	4	27
Cisneros (Antioquia)	1	3	11
Tesalia (Huila)	0	3	17
La Tola (Nariño)	1	3	11
Paz de Río (Boyacá)	0	2	8
Marulanda (Caldas)	0	2	18
Jerusalén (Cundinamarca)	0	2	10
Salento (Quindío)	0	2	21
Betulia (Santander)	0	2	8
Manaure (La Guajira)	22	29	16

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2021-2025, datos preliminares 2026

Tabla 11. Número de casos y proporción de muertes perinatales y neonatales tardías por causa básica agrupada, Colombia, a semana epidemiológica 33, 2024-2026

Entidad territorial de residencia	Número de casos y proporción a semana epidemiológica 33, 2024 -2026					
	2024 a SE 33	(%)	2025 a SE 33	(%)	2026 a SE 33	(%)
Colombia	**3851**	**100,0**	**3566**	**100,0**	**3857**	**100,0**
Asfixia y causas relacionadas	1018	26,4	989	27,7	973	25,2
Prematuridad-inmaturidad	627	16,3	614	17,2	689	17,9
Complicaciones de la placenta, cordón y membranas	586	15,2	547	15,3	540	14,0
Complicaciones maternas del embarazo y trabajo de parto	435	11,3	381	10,7	358	9,3
Infecciones	338	8,8	319	8,9	308	8,0
Malformación congénita	340	8,8	299	8,4	295	7,6
Otras causas de muerte	257	6,7	221	6,2	235	6,1
Sin información	0	0,0	0	0,0	195	5,1
Causas no específicas	98	2,5	58	1,6	137	3,6
Trastornos cardiovasculares	113	2,9	100	2,8	86	2,2
Convulsiones y trastornos neurológicos	19	0,5	19	0,5	26	0,7
Lesión de causa externa	20	0,5	19	0,5	15	0,4

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2024-2026, datos preliminares 2026.
SE: semana epidemiológica.

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

EVENTOS TRAZADORES

Infección Respiratoria Aguda

Metodología

Se elaboró un análisis descriptivo de los casos notificados durante la semana epidemiológica 33 de 2026, a partir de las variables registradas en las fichas epidemiológicas de los eventos colectivos e individuales (códigos INS 995 y 345).

Definición operativa de caso confirmado de morbilidad por IRA: Corresponde a todas las atenciones por IRA en los servicios de consulta externa, urgencias, hospitalización general, UCI/UCIM y defunciones, según los códigos CIE-10 de J00 a J22[1].

Los canales endémicos para consultas externas, urgencias y hospitalizaciones en sala general se realizaron a través de la metodología de Bortman, con los datos de la morbilidad por infección respiratoria aguda a partir del cálculo de la media geométrica, el umbral estacional y el intervalo de confianza, utilizando datos históricos del periodo 2019 a 2025.

El análisis para la identificación de comportamientos inusuales en las entidades territoriales se realizó mediante la metodología Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), que consiste en la comparación del valor observado (número de atenciones por infección respiratoria aguda en los servicios de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y unidades de cuidados intensivos) de la semana actual y las tres anteriores entre los años 2017 a 2025 (valor esperado). Adicionalmente, se calculó el valor de p para establecer si la variación entre lo observado y esperado es estadísticamente significativa.

El análisis del comportamiento de la circulación viral se realizó mediante la metodología Poisson, comparando los datos del periodo anterior y el actual para cada uno de los agentes virales y así mismo por grupo de edad más relevantes para el evento vigilancia centinela código 345.

[1] Instituto Nacional de Salud. Protocolo de vigilancia de infección respiratoria aguda (IRA). Versión 09. 18 de abril de 2024. Disponible en: *https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_IRA%202024.pdf*

En el último periodo (semanas epidemiológicas 30 a 33 de 2026), a nivel nacional, se observó un aumento porcentual en las atenciones por IRA en consulta externa, urgencias, hospitalización en sala general y una disminución en UCI/UCIM frente al periodo anterior (semanas epidemiológicas 26 a 29 de 2026), sin superar el umbral definido para variaciones relevantes (± 30 %) (tabla 12).

Tabla 12. Notificación de morbilidad por infección respiratoria aguda por tipo de servicio en Colombia, semanas epidemiológicas 26 a 29 de 2026 y 30 a 33 de 2026

Atenciones infección respiratoria aguda				
Tipo de servicio	SE 26 a 29 de 2026	SE 30 a 33 2026	Variación porcentual	Tendencia
Consulta externa y urgencias	416 393	437 335	5,03%	
Hospitalización en sala general	19 661	19 836	0,89%	
Hospitalización en UCI/UCIM	2 472	2 448	-0,97%	

Fuente: Instituto Nacional de Salud, Colombia, Sivigila 2026
SE: semana epidemiológica
UCI/UCIM: unidades de cuidado intensivo/unidad de cuidado intermedio

Consulta externa y urgencias por IRA

En la semana epidemiológica 33 del 2026 se notificaron 103 040 atenciones en consulta externa y urgencias por IRA. Teniendo en cuenta el comportamiento de la notificación en los últimos siete años (excluyendo 2020 y 2021), se observó incremento en La Guajira, mientras que Caldas, Santiago de Cali, Caquetá, Cartagena de Indias, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta y Valle del Cauca presentaron disminución. Las 21 entidades territoriales restantes no presentaron comportamientos inusuales.

De acuerdo con el análisis de comportamientos inusuales en municipios con más de 100 000 habitantes, se observó un incremento en seis municipios (tabla 13).

Tabla 13. Comportamientos inusuales de consultas externas y urgencias por infección respiratoria aguda, municipios con más de 100 000 habitantes, Colombia, semanas epidemiológicas 01 a 33 del 2026

Departamento	Municipio	Acumulado 2025	Acumulado 2026	Esperado	Observado
La Guajira	Maicao	41 474	51 418	2 806	6 658
Atlántico	Soledad	59 103	53 655	7 542	6 072
Antioquia	Rionegro	24 365	31 793	2 279	5 165
Antioquia	Itagüí	56 417	48 107	6 244	4 975
Cundinamarca	Soacha	54 868	42 299	5 443	4 967
La Guajira	Uribia	32 083	34 303	2705	4 478
Cundinamarca	Chía	38 558	29 714	4 521	3 479
Antioquia	Bello	41 153	43 764	4 986	3 295
Cundinamarca	Zipaquirá	15 473	14 055	1 895	1 940
Santander	Floridablanca	18 365	17 016	2 072	1 626
Córdoba	Cereté	12 202	13 655	1 415	1 595
Santander	Barrancabermeja	20 728	18 212	1 435	1 555
Boyacá	Sogamoso	13 369	11 069	1 692	1 470
Magdalena	Ciénaga	15 129	12 641	1 682	1 467
Antioquia	Apartadó	11 894	12 927	1 351	1 393
Risaralda	Dosquebradas	19 711	16 004	2 026	1 378
Bolívar	Magangué	14 675	12 401	1 474	1 318
Boyacá	Duitama	14 559	11 608	1 922	1 276
Valle del Cauca	Palmira	18 415	14 538	1 952	1 262
Valle del Cauca	Tuluá	8 927	7 971	867	1 255
Casanare	Yopal	10 149	8 426	1 334	1 215
Córdoba	Lorica	10 319	10 968	1 318	1 202
Antioquia	Envigado	17 850	17 168	2 002	1 189
Cundinamarca	Girardot	14 529	9 889	1 515	1 144
Cundinamarca	Madrid	9 444	10 712	1 273	1 098
Antioquia	Turbo	10 065	9 565	1 051	1 049
Cundinamarca	Facatativá	12 130	8 816	1 687	947
Cundinamarca	Funza	10 574	10 031	805	903
Huila	Pitalito	9 108	6 121	1 128	885
Norte de Santander	Ocaña	11 715	9 064	1 035	885
Cesar	Aguachica	8 034	7 376	981	775
Valle del Cauca	Cartago	11 669	8 372	1 253	775
Valle del Cauca	Buenaventura	4 490	6 701	725	773
Córdoba	Sahagún	16 466	6 024	2 093	744
Santander	Piedecuesta	6 920	6 330	518	643
Cauca	Santander de Quilichao	7 810	5 746	1 068	611
Valle del Cauca	Yumbo	9 976	7 850	1 010	585
Santander	Girón	5 877	5 138	380	531
Cundinamarca	Mosquera	5 098	3 982	459	466
Atlántico	Malambo	4 584	4 625	563	414
Cauca	Guapi	3 186	2 414	232	332
Norte de Santander	Villa del Rosario	4 560	3 993	428	284
Nariño	La Florida	498	433	37	40

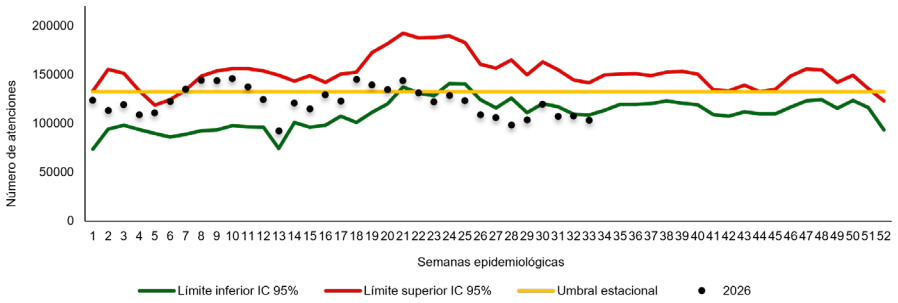
*Del análisis de los municipios se excluyeron las capitales.

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

En las últimas cuatro semanas epidemiológicas (30 a 33 del 2026), por grupos de edad los de 20 a 39 años representaron el 25,3 % (80 463) de las consultas, seguido por el grupo de 5 a 19 años con el 19,8 % (63 212). La mayor proporción de consultas externas y de urgencias por IRA sobre el total de consultas por todas las causas, se presentó en los niños de 1 año con el 8,4 % seguido de los menores de 2 a 4 años con el 7,8 %.

En el canal endémico se observó una tendencia ascendente entre las semanas epidemiológicas 06 y 11, manteniéndose dentro de los límites esperados, con valores que no superaron el límite superior; no obstante, en las semanas epidemiológicas 12 a 17 se registró una disminución, seguida de un nuevo incremento entre las semanas epidemiológicas 18 y 21, manteniéndose dentro de los límites esperados. Posteriormente, entre las semanas 22 y 33 se observó una disminución marcada, ubicándose por debajo del límite inferior (figura 9).

Figura 9. Canal endémico de consultas externas y urgencias por infección respiratoria aguda, Colombia, semanas epidemiológicas 01 a 33 de 2026



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, histórico entre 2018 y 2025

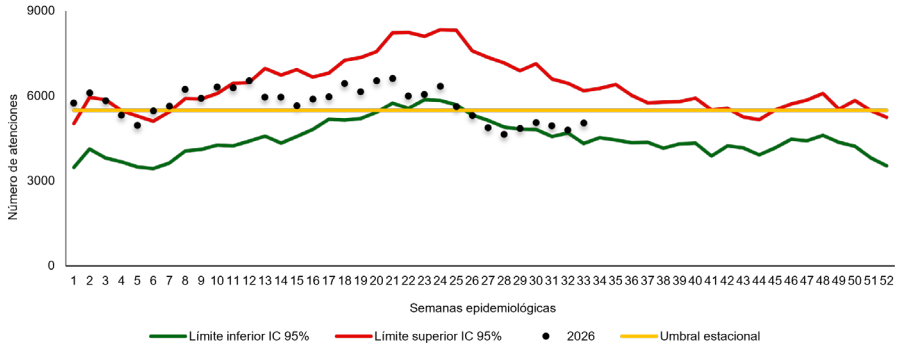
Hospitalizaciones por IRA en sala general

En la semana epidemiológica 33 del 2026 se notificaron 5 047 hospitalizaciones por IRA en sala general. Teniendo en cuenta el comportamiento de la notificación en los últimos siete años se evidenció disminución en Antioquia, Buenaventura, Casanare, Cesar, Guainía, La Guajira, Quindío, Risaralda, San Andrés y Sucre; así mismo, se observó aumento en Amazonas, Arauca, Barranquilla, Cartagena, Guaviare, Magdalena, Nariño y Putumayo. En las 20 entidades territoriales restantes no se presentaron comportamientos inusuales.

En las últimas cuatro semanas epidemiológicas (30 a 33 del 2026), por grupos de edad los mayores de 60 años (5 260) representaron el 26,4 %, seguidos de los menores de 1 año con el 15,1 % (2 996). La mayor proporción de hospitalización en sala general por IRA sobre el total de hospitalizaciones por todas las causas se presentó en el grupo de los niños de 1 año con el 25,3 % seguido de los menores de 2 a 4 años con el 21,0 %.

En el canal endémico de hospitalización por IRA en sala general, las atenciones presentaron una tendencia de incremento sostenido, ubicándose cerca o por encima del límite superior entre las semanas epidemiológicas 01 y 12 de 2026. Entre las semanas epidemiológicas 13 y 24, se observó una disminución de los casos, aunque estos continuaron por encima del umbral estacional. Posteriormente, se observó una disminución sostenida de las hospitalizaciones, situándose por debajo del umbral estacional y acercándose al límite inferior entre las semanas 25 a 33 (figura 10).

Figura 10. Canal endémico de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave en sala general, Colombia, semanas epidemiológicas 01 a 33 de 2026



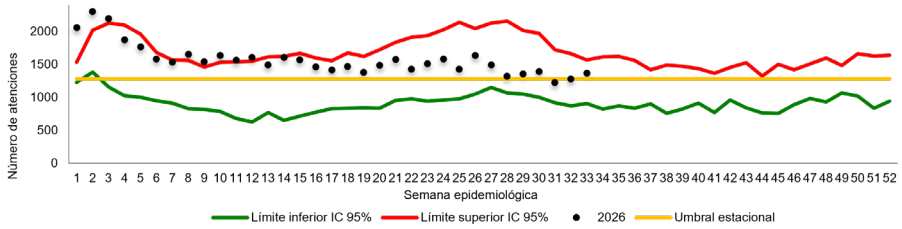
Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia. Histórico 2018 a 2025

Comportamiento en mayores de 60 años por hospitalizaciones por IRA en sala general

En la semana epidemiológica 33 del 2026, se notificaron 1 370 atenciones en hospitalización por IRA en sala general en mayores de 60 años. Frente al canal endémico nacional en este grupo de edad, durante las semanas epidemiológicas 07 a 12 las hospitalizaciones se ubicaron por encima del límite superior, presentaron un descenso entre las semanas epidemiológicas 13 y 32 de 2026, ubicándose dentro de lo esperado (figura 11).

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Figura 11. Canal endémico hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave en sala general en mayores de 60 años, Colombia, semanas epidemiológicas 01 a 33 de 2026



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia. Histórico 2018 a 2025

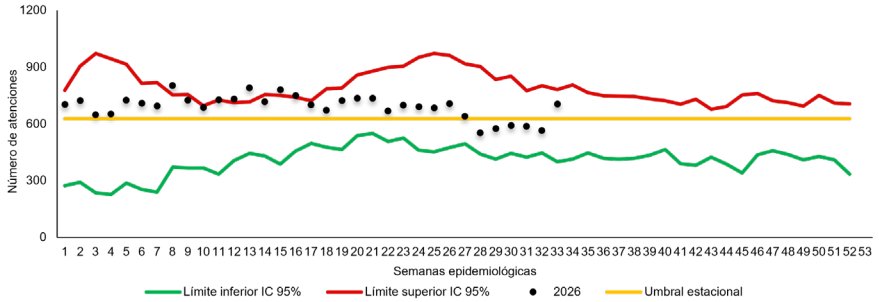
Hospitalizaciones por IRA en unidades de cuidados intensivos e intermedios (UCI/UCIM)

En la semana epidemiológica 33 del 2026 se notificaron 704 hospitalizaciones por IRA en UCI/UCIM; se observó incremento en las entidades territoriales de Arauca, Cauca, Guaviare y San Andrés. Se registró disminución en Antioquia, Bolívar, Buenaventura, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Sucre y Vaupés. En las demás entidades territoriales no se presentaron comportamientos inusuales.

En las últimas cuatro semanas epidemiológicas (30 a 33 del 2026), por grupos de edad los mayores de 60 años representaron el 35,0 % (859), seguido de los menores de 1 año con el 25,0 % (614) de las hospitalizaciones. La mayor proporción de hospitalizaciones por IRA en UCI/UCIM sobre el total de hospitalizaciones en UCI por todas las causas se presentó en el grupo de los niños de 1 año con el 19,0 % seguido del grupo de 2 a 4 años con el 15,9 %.

En el canal endémico de hospitalizaciones por IRA en UCI/UCIM a nivel nacional, durante las semanas epidemiológicas 01 a 16 y 33 de 2026, las atenciones se mantuvieron predominantemente por encima del umbral estacional, alcanzando el límite superior del canal en las semanas 08, 11 a 13, 15 y 16, seguido de un descenso progresivo entre las semanas epidemiológicas 17 a 32 (figura 12).

Figura 12. Comportamiento de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave en unidades de cuidados intensivos, Colombia, semanas epidemiológicas 01 a 33 de 2026

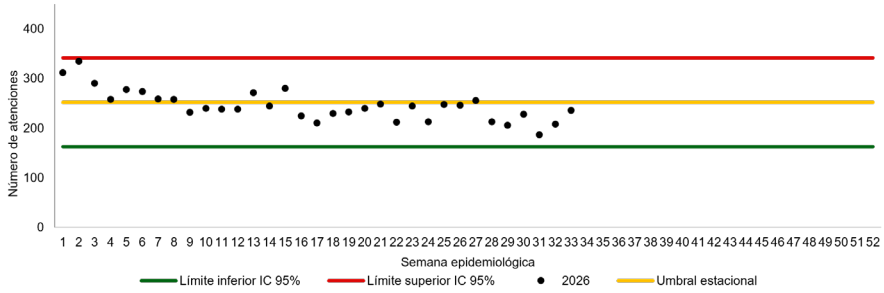


Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia. Histórico entre 2018 y 2025

Comportamiento en los mayores de 60 años por hospitalizaciones por IRA en UCI/UCIM

En la semana epidemiológica 33 del 2026, se notificaron 236 atenciones en hospitalización por IRA en UCI/UCIM en mayores de 60 años. En el gráfico de control nacional para este grupo de edad, las hospitalizaciones se mantuvieron por encima del umbral estacional durante las semanas epidemiológicas 01 a 08, 13 y 15 de 2026; no obstante, en las semanas 09 a 12, 14 y 16 a 33 de forma intermitente se observó un descenso, ubicándose por debajo de dicho umbral (figura 13).

Figura 13. Comportamiento de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave en unidades de cuidados intensivos, mayores de 60 años, Colombia, semanas epidemiológicas 01 a 33 de 2026



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia. Histórico entre 2018 y 2025

Durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas se observó una variación porcentual negativa en la notificación de atenciones por IRA en UCI/UCIM y positiva en consulta externa, urgencias, hospitalización en sala general con respecto al periodo

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

anterior. Los grupos de edad con mayor proporción de atenciones en los tres servicios vigilados corresponden a menores de 5 años y mayores de 60 años.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), durante agosto de 2026 las condiciones climáticas del país estarán influenciadas por el fortalecimiento de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño, junto con la variabilidad estacional e intraestacional. Se prevén precipitaciones por debajo de lo normal en amplios sectores de las regiones Caribe y Andina, así como en el Archipiélago de San Andrés y Providencia. Para el periodo agosto a octubre de 2026, esta tendencia deficitaria se intensificaría y se extendería a otras regiones del país. Asimismo, se espera un predominio de anomalías positivas en la temperatura media del aire entre agosto de 2026 y enero de 2027. Estas condiciones de disminución de las precipitaciones y aumento de la temperatura, asociadas al fortalecimiento del fenómeno El Niño, podrían favorecer la suspensión y concentración de material particulado en el aire, así como la circulación de agentes respiratorios, incrementando el riesgo de infecciones respiratorias agudas (IRA), especialmente en poblaciones vulnerables[1].

Adicionalmente, en el contexto de la emergencia generada por el sismo ocurrido recientemente, las condiciones de hacinamiento temporal en albergues, la interrupción de servicios básicos, los desplazamientos poblacionales y las dificultades en el acceso oportuno a los servicios de salud podrían favorecer la transmisión de agentes respiratorios y aumentar la susceptibilidad de la población afectada a presentar IRA. Este riesgo puede ser mayor en grupos vulnerables como niños, personas mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas.

En este contexto, la interacción entre las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño, caracterizadas por la disminución de las precipitaciones y el aumento de la temperatura, la emergencia derivada del sismo y la circulación estacional de virus respiratorios podría favorecer un incremento de la morbilidad por infección respiratoria aguda (IRA)

Considerando el contexto de la emergencia por terremoto en las entidades territoriales afectadas, las condiciones climáticas previstas, la estacionalidad del evento y el comportamiento epidemiológico esperado de las infecciones respiratorias agudas, se recomienda a las entidades territoriales:

- Fortalecer las acciones de prevención y control de infecciones respiratorias en albergues temporales, centros de evacuación y otros espacios de alojamiento colectivo, promoviendo la ventilación adecuada de los espacios, la identificación temprana y separación de personas con síntomas respiratorios, la disponibilidad de puntos para higiene de manos y la adopción de medidas de protección individual según el nivel de riesgo.
- Garantizar el acceso oportuno a servicios de salud y medicamentos esenciales para la atención de enfermedades respiratorias, especialmente en las poblaciones afectadas por la emergencia.
- Fortalecer la vigilancia epidemiológica comunitaria en las zonas afectadas por el terremoto, con el fin de identificar oportunamente incrementos inusuales de síntomas respiratorios, conglomerados o brotes, y facilitar la implementación de medidas de control de manera temprana.
- Priorizar la protección de grupos vulnerables en los albergues y comunidades afectadas, incluyendo menores de cinco años, personas mayores, gestantes, personas con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos y personas con discapacidad, garantizando condiciones adecuadas de alojamiento, acceso a agua potable y atención en salud.
- Coordinar acciones intersectoriales con los organismos de gestión del riesgo, autoridades locales y entidades del sector salud para reducir las condiciones que favorecen la transmisión de infecciones respiratorias, incluyendo el control del hacinamiento, la mejora de las condiciones de saneamiento básico y la adecuada gestión de espacios temporales de alojamiento.
- Mantener la disponibilidad de insumos para la prevención y control de infecciones respiratorias, tales como tapabocas, soluciones para higiene de manos y elementos de limpieza y desinfección, especialmente en las áreas con mayor afectación por la emergencia.

Circulación de agentes microbianos causantes de IRA

La actividad de influenza en la región de las Américas durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas se mantiene en descenso. El virus dominante (50,8 %) a nivel regional corresponde a influenza B, en las subregiones se distribuye así: Caribe y Brasil y Cono Sur influenza B mientras que en Centroamerica y Andina influenza A(H3N2). Respecto a virus sincitial respiratorio (VSR) se reportaron niveles ascendentes de circulación en las subregiones Centroamérica y Brasil y cono Sur. Con relación a SARS-CoV-2 se mantiene estable y en niveles bajos en la mayoría de las subregiones, excepto en Caribe donde alcanza un 10,6 % de positividad. Para más información consulte Flunet Home Page (datos regionales).

En el último periodo analizado, correspondiente a la semana epidemiológica 33, la actividad viral estuvo marcada por la presencia de virus respiratorio sincitial (VSR),

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

rinovirus, adenovirus, *metapnemovirus*, parainfluenza e influenza. Al comparar los dos periodos epidemiológicos, se evidencia un comportamiento al incremento en la positividad general. Los patógenos que presentaron significancia estadística para el periodo analizado fueron al incremento rinovirus, influenza B y coronavirus. El VSR se encuentra en decremento. Los demás virus respiratorios se mantienen estables en los últimos dos periodos. Ante este comportamiento, se recomienda reforzar la vacunación contra influenza en los grupos priorizados, conforme a las directrices del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) (tabla 14). Se insta a las entidades territoriales a mantener una vigilancia activa ante la concurrencia de la circulación de influenza estacional y otros virus respiratorios, situación que eventualmente podría generar una presión significativa sobre los sistemas de salud.

Tabla 14. Circulación viral identificada en la vigilancia centinela, Colombia, semanas epidemiológicas 26 a 33 de 2026

Agente viral identificado	SE 26 a 29 de 2026			SE 30 a 33 de 2026			Variación total
	Total	< 5 años	> 60 años	Total	< 5 años	> 60 años	
Positividad general	**52,9**	**60,4**	**31,3**	**54,1**	**58,7**	**42,6**	
Rinovirus	7,6	6,8	-	14,1	14,8	-	
Virus sincital respiratorio	35,9	47,6	12,0	19,7	27,8	10,0	
Enterovirus	4,8	3,9	4,0	6,6	3,5	25,0	
Adenovirus	7,2	8,3	-	6,1	6,1	10,0	
Influenza B	2,8	1,5	-	6,6	1,7	5,0	
Influenza A	15,5	12,1	24,0	18,7	16,5	15,0	
Parainfluenza	10,7	8,7	20,0	8,1	10,4	5,0	
Metapnemovirus	3,1	3,9	4,0	3,5	5,2	-	
A(H1N1)pdm09	2,8	0,5	12,0	1,0	1,7	-	
SARS-CoV-2	2,1	1,9	4,0	2,5	1,7	10,0	
A(H3N2)	5,9	3,9	12,0	7,5	7,0	10,0	
Coronavirus	1,7	1,0	8,0	5,6	3,5	10,0	

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026.
Porcentajes calculados del total de muestras analizadas con resultado positivo para algún agente viral.
**Se muestra la variación con significancia estadística*

Referencia

1. Instituto Nacional de Salud (INS), Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Boletín de clima y salud. Edición No. 8. agosto de 2026. Bogotá, D.C.: INS; 2026.

COVID-19

Metodología

Se elaboró un informe descriptivo de los casos notificados hasta la semana epidemiológica (SE) 33 de 2026, considerando las variables de tiempo, lugar y persona registradas en la ficha de datos básicos del evento COVID-19 (código INS 346).

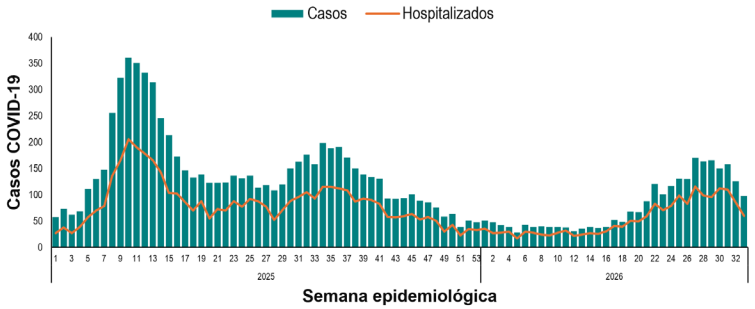
Definición operativa del evento: persona con resultado positivo para SARS-CoV-2, independientemente de criterios clínicos o epidemiológicos, con o sin requerimiento de hospitalización.

El análisis del comportamiento se realizó mediante la comparación de los casos confirmados de COVID-19. Los comportamientos inusuales por departamentos y municipios se evaluaron comparando las cuatro semanas previas con las actuales. La interpretación se definió así: incremento (razón > 1 con significancia estadística, $p < 0,05$), decremento (razón < 1 con significancia estadística, $p < 0,05$) y sin cambio (razón cercana a 1 sin significancia estadística, $p > 0,05$).

25

En lo corrido de 2026 (semana epidemiológica 01 a 33), con corte al 22 de agosto y según fecha de inicio de síntomas, se notificaron al Sivigila 2 618 casos de COVID-19, de los cuales 2 616 son procedentes de Colombia y dos (2) del exterior. En las últimas cuatro semanas (semanas epidemiológicas 30 a 33) se registraron 536 casos, una disminución del 15,5 % frente al periodo anterior (semanas epidemiológicas 26 a 29), en el que se reportaron 634 casos. Respecto a las hospitalizaciones, se notificaron 367 casos, una disminución del 6,9 % frente a las 394 del periodo anterior. Con el mismo periodo de 2025 (SE 30 a 33), en el que se notificaron 652 casos, se observa una disminución en 2026 del 17,8 % respecto al año anterior (figura 14).

Figura 14. Comportamiento temporal de casos notificados de COVID-19 en Colombia, semanas epidemiológicas 01 a 53 de 2025 y 01 a 33 de 2026



Fuente: Sivigila, SE 01 a 53 de 2025 y 01 a 33 de 2026
**SE: semana epidemiológica*

Durante el periodo epidemiológico actual (semanas epidemiológicas 30 a 33 de 2026) se registró una incidencia de 1,0 casos por cada 100 000 habitantes, con afectación en 35 entidades territoriales de orden departamental y distrital, y en 115 municipios del país.

En comparación con el periodo anterior (semanas epidemiológicas 26 a 29 de 2026), se evidenció un incremento significativo en la notificación de casos de COVID-19 en los departamentos de Norte de Santander, Tolima y Arauca.

A nivel municipal, este aumento se observó en Arauquita (Arauca), San José de Cúcuta (Norte de Santander), Neiva (Huila) y Ibagué (Tolima).

Entre el periodo epidemiológico anterior (semanas epidemiológicas 26 a 29 de 2026) y el periodo actual (semanas epidemiológicas 30 a 33 de 2026), se observó una disminución del 15,5 % en la notificación total de casos, pasando de 634 a 536 casos. No obstante, algunos grupos de edad presentaron incrementos durante el periodo evaluado. Los mayores aumentos porcentuales se registraron en los grupos de 90 a 99 años (57,1 %), 5 a 9 años (19,2 %), 50 a 59 años (14,3 %), 30 a 39 años (9,7 %) y 2 a 4 años (3,8 %).

En contraste, la mayoría de los grupos de edad mostraron reducciones en la notificación de casos. Las disminuciones más importantes se observaron en el grupo de 40 a 49 años (-60,0 %), seguido de menores de un año (-25,2 %), 70 a 79 años (-25,0 %), 60 a 69 años (-22,2 %), 80 a 89 años (-22,2 %), 1 año (-15,3 %), 20 a 29 años (-11,5 %) y 10 a 19 años (-10,8 %). Por su parte, el grupo de mayores de 100 años no registró casos en ninguno de los dos periodos analizados, por lo que no fue posible calcular la variación porcentual (NC) (tabla 15).

Tabla 15. Distribución de casos de COVID-19 por grupos de edad en las últimas ocho semanas epidemiológicas (26 a 33) de 2026

Grupos de edad	PE anterior	PE actual	Variación porcentual	Tendencia
	SE 26 a 29 2026	SE 30 a 33 2026		
Menor de un año	222	166	-25,2	
1 año	72	61	-15,3	
2 a 4 años	52	54	3,8	
5 a 9 años	26	31	19,2	
10 a 19 años	37	33	-10,8	
20 a 29 años	26	23	-11,5	
30 a 39 años	31	34	9,7	
40 a 49 años	30	12	-60,0	
50 a 59 años	28	32	14,3	
60 a 69 años	36	28	-22,2	
70 a 79 años	40	30	-25,0	
80 a 89 años	27	21	-22,2	
90 a 99 años	7	11	57,1	
Mayor de 100 años	0	0	NC	
Total	634	536	-15,5	

Nota: *las variaciones porcentuales elevadas en algunos grupos de edad deben interpretarse con cautela, dado el bajo número de casos absolutos en el periodo anterior. Un cambio de pocos casos puede traducirse en porcentajes altos sin reflejar necesariamente una tendencia sostenida.*

• NC: no calculable
Fuente: Sivigila SE 26 a 33 de 2026
PE: periodo epidemiológico SE: semana epidemiológica

En lo corrido de 2026, se han notificado en Colombia 24 fallecimientos asociados a COVID-19: ocho (8) en Bogotá D. C.; cinco (5) en el departamento de Arauca, de los cuales cuatro ocurrieron en el municipio de Arauca y uno en Saravena; y uno en cada uno de los siguientes municipios: Peñol (Antioquia), Rionegro (Antioquia), Montería (Córdoba), Pasto (Nariño), Montenegro (Quindío), Astrea (Cesar), Riohacha (La Guajira), Pereira (Risaralda), Pivijay (Magdalena), Santiago de Cali (Valle del Cauca) y Pore (Casanare).

Para obtener más información sobre el COVID-19, consulte el enlace ***http://url.ins.gov.co/uu7la***, donde podrá ampliar los detalles sobre los casos de COVID-19 en Colombia entre 2020 y 2026.

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Dengue

Metodología

Se realizó un informe descriptivo de los casos notificados durante la semana epidemiológica 33 de 2026, teniendo en cuenta las variables de tiempo, persona y lugar contenidas en la ficha de datos básicos y complementarios del evento de dengue, dengue grave y mortalidad por dengue (Código INS 210, 220 y 580).

Para el análisis de la información se tuvo en cuenta las siguientes definiciones de caso establecidas en el protocolo de vigilancia en salud pública del evento1:

Caso probable de dengue: Paciente procedente de área endémica que cumple con la definición de dengue con o sin signos de alarma.

- **Dengue sin signos de alarma:** enfermedad febril aguda de 2 a 7 días de evolución en la que se observan dos o más de las siguientes manifestaciones: cefalea, dolor retro-ocular, mialgias, artralgias, erupción cutánea, rash o leucopenia.
- **Dengue con signos de alarma:** paciente que cumple con la anterior definición y además presenta cualquiera de los siguientes signos de alarma: dolor abdominal intenso y continuo o dolor a la palpación, vómitos persistentes, diarrea, acumulación de líquidos (ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico), sangrado en mucosas, letargo o irritabilidad (principalmente en niños), hipotensión postural, hepatomegalia dolorosa >2 cm, caída de la temperatura, caída abrupta de plaquetas (<100 000) asociada a hemoconcentración.
- **Dengue grave:** todo caso de dengue que cumple con cualquiera de las manifestaciones graves de dengue que se mencionan a continuación: • Extravasación severa de plasma: Que conduce a síndrome de choque por dengue o acúmulo de líquidos con dificultad respiratoria. • Hemorragias severas: Paciente con enfermedad febril aguda, que presenta hemorragias severas con compromiso hemodinámico. • Daño grave de órganos: Paciente con enfermedad febril aguda y que presente signos clínicos o paraclínicos de daño severo de órganos como: daño hepático, daño del sistema nervioso central, corazón o afección de otros órganos.
- **Muerte por dengue:** todo caso que fallece con diagnóstico de dengue grave.

Caso confirmado de dengue: caso probable de dengue, dengue grave, o mortalidad por dengue confirmado por alguno de los criterios de laboratorio para el diagnóstico de dengue: ELISA NS1, RT-PCR o aislamiento viral en pacientes con 5 días o menos de inicio de síntomas o prueba de IgM Dengue ELISA en pacientes con 6 o más días de inicio de síntomas.

El canal endémico nacional y el análisis del comportamiento epidemiológico por entidad territorial se construyó con la metodología de medias geométricas (Marcelo Bortman), con los siguientes límites de control: **por debajo de lo esperado**, número de casos menor al límite inferior IC95 %; **dentro de lo esperado**, número de casos entre el límite inferior y la media geométrica IC95 %; **en alerta**, número de casos entre la media geométrica y el límite superior IC95 %, y **por encima de lo esperado**, número de casos por encima del límite superior IC95 %.

1. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de vigilancia en salud pública de dengue. Versión 4. 20 de marzo de 2022. Disponible en *https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Dengue.pdf*

Definición de periodo de transmisión: corresponde al comportamiento esperado mensualmente según el comportamiento histórico (2019-2025 sin 2021)

Alta transmisión	Moderada transmisión	Baja transmisión
Entidades territoriales que presentan durante el mes analizado una frecuencia de casos superior al promedio anual en al menos 5 años de su histórico (2019-2025 sin 2021).	Entidades territoriales que presentan durante el mes analizado una frecuencia de casos superior al promedio anual en 3 o 4 años de su histórico (2019-2025 sin 2021).	Entidades territoriales que presentan durante el mes analizado una frecuencia de casos superior al promedio anual en 0 o 2 años de su histórico (2019-2025 sin 2021).

El porcentaje de municipios **por encima de lo esperado** para dengue se calculó teniendo en cuenta como denominador el número de municipios en riesgo para el evento por departamento, según lo indicado en el *Lineamiento metodológico para la estratificación y estimación de la población en riesgo para arbovirosis en Colombia* 2020-2023 del Ministerio de Salud y Protección Social.

En la semana epidemiológica 33 del 2026 se notificaron 2 731 casos de dengue: 1 950 casos de esta semana y 781 casos de semanas anteriores. Según el acumulado, se registran 72 546 casos, 43 781 (60,4 %) sin signos de alarma, 28 038 (38,6 %) con signos de alarma y 727 (1,0 %) de dengue grave.

El 67,7 % (49 114) de los casos a nivel nacional proceden de Meta, Bolívar, Cesar, Santander, Norte de Santander, Magdalena, Casanare, La Guajira, Cartagena de Indias D. T. y Antioquia (tabla 16). Sin embargo, durante el último periodo (semanas epidemiológicas 29 a 32 de 2026) se observa que las entidades territoriales de Meta, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Casanare, Magdalena, Cesar y Atlántico concentran el 64,9 % (6 528 casos) de los casos del periodo.

En el último periodo analizado (semanas epidemiológicas 29 a 32 de 2026) con respecto al periodo anterior (semanas epidemiológicas 25 a 28, 2026), se observó una tendencia al aumento superior al 30,0 % en Archipiélago de San Andrés y Providencia, Barranquilla, Cauca, Guaviare, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima y Vaupés; una tendencia al descenso mayor a 30 % en las entidades territoriales de Buenaventura, Caquetá y La Guajira, mientras que, las demás entidades territoriales mantuvieron un comportamiento estable (tabla 16).

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

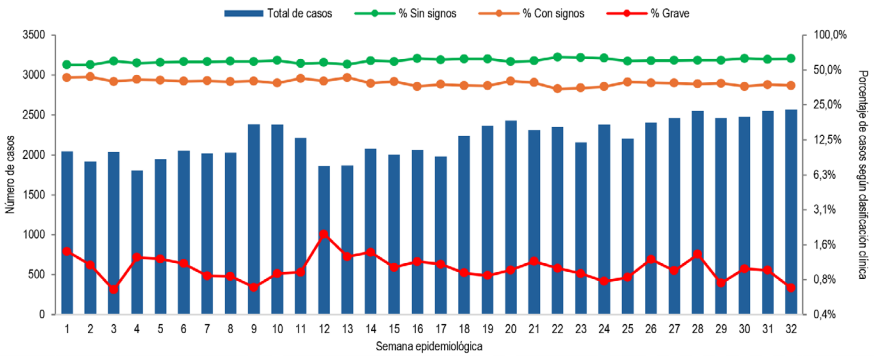
Tabla 16. Casos notificados de dengue por entidad territorial de procedencia y clasificación, Colombia, a semana epidemiológica 33 de 2026

Entidad territorial	Total Casos	Porcentaje de casos según clasificación		Variación último período	
		Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Esperado (SE 25 - 28 2026)	Observado (SE 29-32 2026)
Meta	11911	29.8	0.9	1602	1521
Bolívar	6293	40.8	1.4	1033	1028
Cesar	5785	56.5	0.7	697	504
Santander	4815	38.4	0.7	649	695
Norte de Santander	4622	37.6	1.4	557	800
Magdalena	4273	50.1	0.7	522	513
Casanare	3054	30.0	0.6	714	625
La Guajira	3035	53.6	1.7	208	78
Cartagena	2713	19.5	1.0	219	183
Antioquia	2633	37.3	1.0	414	378
Atlántico	2389	44.4	0.8	356	435
Córdoba	2381	42.9	0.4	284	212
Barranquilla	2227	45.3	0.8	224	298
Tolima	2151	31.9	1.3	266	365
Santa Marta	2001	44.8	0.3	87	64
Arauca	1994	31.0	1.2	298	348
Sucre	1360	48.0	1.0	194	280
Valle del Cauca	1175	36.1	0.9	190	219
Cundinamarca	1158	37.4	0.9	184	185
Cali	948	37.2	0.3	115	130
Huila	928	37.1	4.3	106	175
Guaviare	858	19.5	0.2	162	407
Chocó	718	21.7	1.1	114	112
Amazonas	580	15.0	0.2	57	81
Nariño	537	39.9	0.9	85	88
Caquetá	393	51.1	2.3	29	19
Putumayo	316	27.2	1.6	22	70
Quindío	272	26.1	1.8	50	48
Boyacá	207	47.3	1.9	54	38
Cauca	153	34.0	2.6	17	34
Exterior	140	45.7	2.9	23	22
Caldas	139	39.6	0.0	23	21
Risaralda	128	40.6	1.6	23	19
Buenaventura	99	32.3	1.0	15	10
Vichada	77	29.9	0.0	13	12
Vaupés	49	10.2	0.0	12	26
Archipiélago de San Andrés	27	29.6	3.7	4	13
Guainía	7	28.6	0.0	0	1
Total	**72 546**	**38.6**	**1.0**	**9 622**	**10 057**

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026. SE: semana epidemiológica.

A la fecha, el porcentaje de dengue con signos de alarma y dengue grave se mantiene alrededor del 40 % a nivel nacional (figura 15); sin embargo, las entidades territoriales que presentaron un porcentaje superior al 50,0 % en la presentación de casos de dengue con signos de alarma y dengue grave en el último periodo analizado (semanas epidemiológicas 29 a 32 de 2026) fueron: Boyacá, Caquetá, Cesar, Córdoba y La Guajira.

Figura 15. Proporción de casos de dengue según clasificación clínica, Colombia, a semana epidemiológica 33, 2026

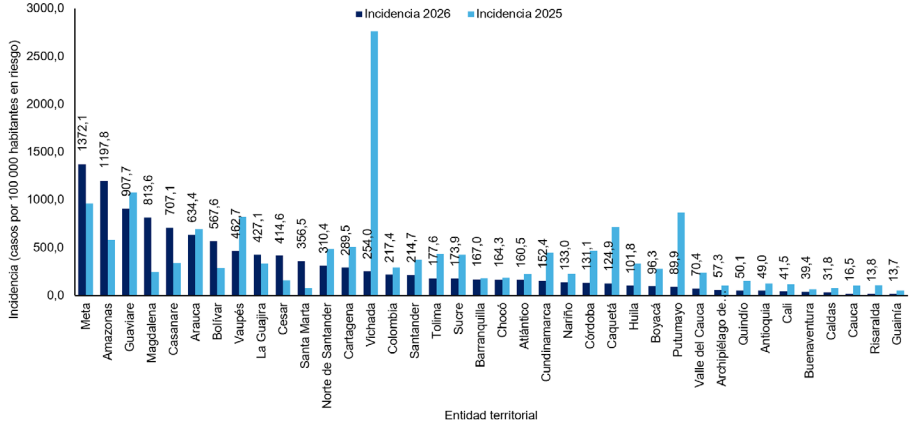


Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026

A la semana epidemiológica 33 del 2026, la incidencia nacional de dengue es de 217,4 casos por cada 100 000 habitantes en riesgo; para el mismo periodo del 2025 la incidencia fue de 292,7 casos por 100 000 habitantes. De las 38 entidades territoriales departamentales y distritales de Colombia, Bogotá D. C. es la única entidad sin población a riesgo para el evento. Las entidades territoriales de Meta, Amazonas, Guaviare, Magdalena, Casanare, Arauca y Bolívar presentan las mayores incidencias a la semana epidemiológica 33 del 2026, con tasas superiores a 560,0 casos por 100 000 habitantes (figura 16). Por grupo de edad, la mayor incidencia de dengue se observó en los menores de 17 años con 443,3 casos por 100 000 habitantes.

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Figura 16. Incidencia de dengue por entidad territorial de procedencia en Colombia, a semana epidemiológica 33 de 2025 y 2026

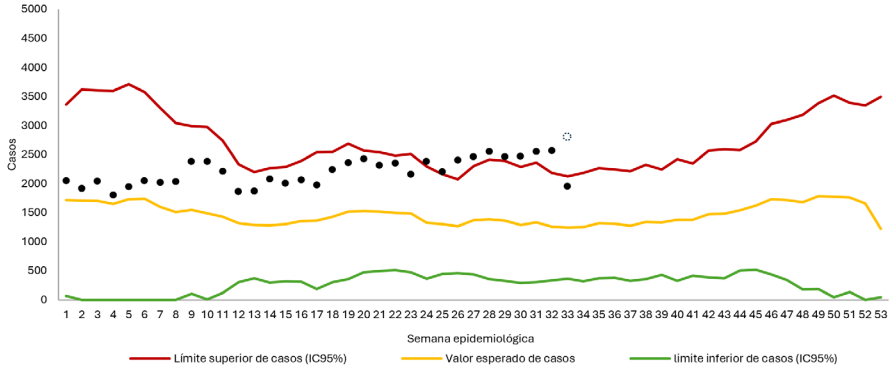


Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026

A la semana epidemiológica 33 del 2026, el evento a nivel nacional, según el canal endémico se ubicó en situación de brote, comparado con su comportamiento histórico, con una tendencia al aumento en las últimas semanas con una variación de 4,5 % en el último periodo analizado (semanas epidemiológicas 29 – 32 de 2026) con respecto al periodo anterior (semanas epidemiológicas 25 – 28, 2026) (figura 17). En 2026 (semanas epidemiológicas 01 - 33), se observa una reducción del 25,7 % en la notificación de casos de dengue a nivel nacional en comparación con el mismo periodo de 2025 donde se habían notificado 97 479 casos.

De acuerdo con la situación epidemiológica de las entidades territoriales departamentales y distritales en riesgo para dengue en general, según el canal endémico, se observa que el 18,9 % (7) está dentro de lo esperado, el 40,5 % (15) se encuentra en situación de alerta y el 40,5 % (15) supera el límite superior esperado, comparado con el comportamiento histórico; este patrón es consistente con la situación epidemiológica observada a nivel nacional (tabla 17).

Figura 17. Canal endémico de dengue, Colombia, a semana epidemiológica 33 de 2026



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026

Tabla 17. Comportamiento epidemiológico de las entidades territoriales según el periodo de transmisión histórico de la enfermedad, Colombia, semana epidemiológica 33 del 2026

Situación epidemiológica semana epidemiológica 33, 2026	Entidad territorial
Por encima del límite superior esperado	Amazonas, Arauca, Atlántico, Bolívar, Barranquilla D. E., Cesar, Casanare, Meta, Guaviare, Quindío, Magdalena, Norte de Santander, Santa Marta D.T., Archipiélago de San Andrés y Providencia, Vaupés.
Alerta	Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Cartagena de Indias D. T., Chocó, La Guajira, Huila, Nariño, Santander, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca, Tolima, Vichada
Dentro de lo esperado	Buenaventura D. E., Cauca, Córdoba, Santiago de Cali D. E., Caquetá, Guainía, Risaralda.

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026

A nivel municipal, en la semana epidemiológica 33 del 2026 se observó que, de los 825 municipios en riesgo para dengue en el país el 19,3 % (159) se encuentra por encima de lo esperado, según canal endémico para dengue. De los municipios con población mayor a 100 000 habitantes en riesgo para dengue el 26,2 % (15/57) se sitúan por encima de lo esperado, comparado con su comportamiento histórico (tabla 18).

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Tabla 18. Municipios por encima de lo esperado según canal endémico de dengue con población mayor a 100 000 habitantes en riesgo para dengue, Colombia, semana epidemiológica 33 de 2026

Departamento	Municipio	Incidencia acumulada	Total casos	Variación último periodo	
		Casos por 100 000 habitantes		(SE 25-28 2026)	(SE 29-32 2026)
Antioquia	Medellín	14.0	367	48	58
	Envigado	15.3	37	8	7
Atlántico	Barranquilla	169.8	2227	224	298
Bolívar	Magangué	345.1	496	76	101
	Turbaco	404.0	470	50	51
Cesar	Aguachica	478.4	588	97	106
Córdoba	Cereté	224.5	247	45	32
Chocó	Quibdó	111.3	148	31	23
La Guajira	Riohacha	491.7	1030	85	33
Santa Marta	Santa Marta	362.2	2001	87	64
Meta	Villavicencio	1656.0	8444	1037	942
Norte de Santander	Ocaña	238.5	283	51	92
Santander	Bucaramanga	278.0	1721	238	284
Arauca	Arauca	279.0	280	51	53
Casanare	Yopal	330.7	597	181	182

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026. SE: semana epidemiológica.

A la semana epidemiológica 33 del 2026, se han notificado 188 muertes probables por dengue de las cuales 42 han sido confirmadas, se han descartado 103 casos y 43 casos se encuentran en estudio. A la fecha, la letalidad nacional por dengue es de 0,06 %, inferior a la meta establecida (Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031: <0,10 %). Para el mismo periodo de 2025, se confirmaron 89 muertes por dengue procedentes de Colombia (letalidad por dengue: 0,09 %) (tabla 19).

Tabla 19. Letalidad por dengue por entidad territorial de procedencia, Colombia, a semana epidemiológica 33, 2025-2026

Entidad territorial de procedencia	Casos fatales 2026		Letalidad por dengue a SE 33, 2026	Letalidad por dengue a SE 33, 2025
	Confirmados	En estudio		
La Guajira	10	1	0.33	0.04
Huila	2	2	0.22	0.20
Atlántico	3	0	0.13	0.06
Magdalena	5	2	0.12	0.08
Santa Marta D.E.	2	0	0.10	0.24
Cundinamarca	1	1	0.09	0.06
Bolívar	5	6	0.08	0.09
Antioquia	2	3	0.08	0.12
Sucre	1	1	0.07	0.06
Cesar	3	1	0.05	0.05
Norte de Santander	2	1	0.04	0.04
Meta	5	8	0.04	0.12
Santander	1	1	0.02	0.08
Tolima	0	4	0.00	0.04
Valle del Cauca	0	3	0.00	0.00
Arauca	0	2	0.00	0.09
Casanare	0	2	0.00	0.00
Putumayo	0	2	0.00	0.16
Barranquilla	0	1	0.00	0.12
Boyacá	0	1	0.00	0.00
Nariño	0	1	0.00	0.00
Colombia	**42**	**43**	**0,06**	**0,09**

VPP (valor predictivo positivo) muertes por dengue: 30 %. SE: semana epidemiológica.
**No se incluyen en esta tabla los casos procedentes del exterior*
Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2025-2026.

Para ampliar la información sobre el comportamiento del evento puede consultarse el tablero de control de dengue dispuesto en el siguiente enlace: ***http://url.ins.gov.co/-2i6o***

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Malaria

Metodología

Se realizó un análisis descriptivo con corte a semana epidemiológica 33 de 2026, con información que incluye: descripción de los casos en tiempo, lugar y persona, análisis de tendencia, comportamientos inusuales, descripción y análisis de indicadores para la vigilancia. El porcentaje de municipios en brote y alarma se obtuvo del análisis de las últimas cuatro semanas epidemiológicas desde la revisión de canales endémicos con metodología de mediana y comportamientos inusuales de incrementos y decrementos, en el apartado de comportamientos inusuales se realizó una comparación de cuatro semanas previas y actuales; el campo observado se interpreta así: color amarillo es aumento, gris decremento, sin color indica que no presentó cambios.

Definición operativa del evento: paciente con episodio febril (> 37,5° C) actual o reciente (hasta de dos semanas o 15 días previos a la consulta), procedente de área o región endémica de malaria en los últimos 15 días, cuya enfermedad se confirme por la identificación de especies de Plasmodium spp, mediante algún examen parasitológico como: (gota gruesa), pruebas rápidas de detección de antígeno parasitario (PDR), o en situaciones especiales, técnica molecular (PCR)[1].

Estratificación de riesgo: para Colombia han sido definidos cinco estratos de riesgo, determinados según los siguientes criterios: receptividad (posibilidad del ecosistema para permitir la transmisión de la malaria, es decir que el territorio tenga una altura por debajo de 1 600 msnm y que se encuentre el vector), la intensidad de la transmisión (nivel de endemicidad o número de casos autóctonos en los últimos 10 años) y el riesgo de importación del parásito (concepto asociado a la movilización de personas, movimientos migratorios internos o externos entre municipios).

Estrato	Receptividad	Riesgo de importación	Casos autóctonos		Casos en el último año		Observaciones
			10 años	3 años	>3 casos autóctonos por semana por unidad que reporta	≤ 3 casos autóctonos por semana por unidad que reporta (hasta 156 por año)	
1	NO	NO	NO	NO	0	0	Altitud mayor o igual a 1.600 ms. n. m. (-) vector
2	SI	NO	NO	NO	0	0	(+) focos eliminados
3	SI	SI	SI/NO	NO	0	0	(+) focos eliminados
4	SI	SI	SI	SI	0	SI	(+) focos activos y residuales
5	SI	SI	SI	SI	SI	-	(+) focos activos y residuales

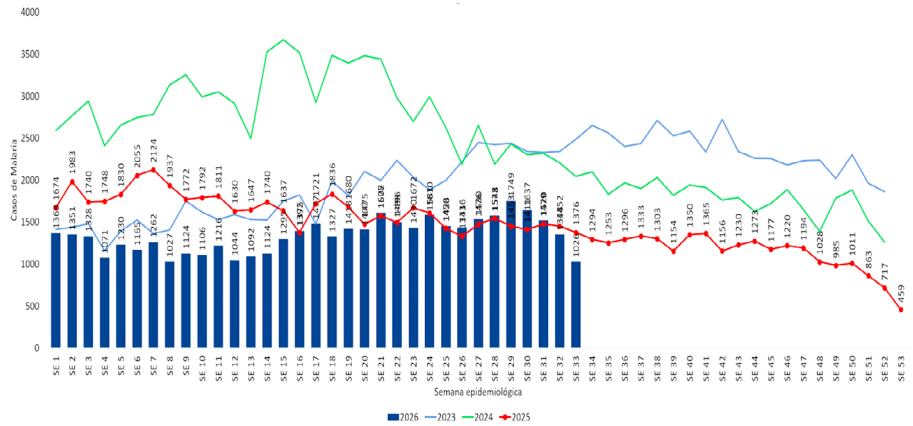
Las tasas de incidencia de malaria no complicada se calcularon considerando la población en riesgo. Para la interpretación y representación visual, se utilizó una escala de colores basada en cuartiles: los tonos más oscuros indican un mayor riesgo de aparición de casos, mientras que los tonos más claros reflejan un menor riesgo.

[1] Instituto Nacional de Salud. Protocolo de vigilancia de malaria. Versión 5. 17 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Malaria%202022.pdf

Análisis epidemiológico nacional

Según el análisis del último periodo epidemiológico, el país se encuentra en situación de disminución por malaria, como lo muestra la figura 18.

Figura 18. Comportamiento epidemiologico de malaria, Colombia, semanas epidemiológicas 01 a 53 del 2023 al 2025 y semana epidemiológica 01 a 33 de 2026



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia 2026

En la semana epidemiológica 33 del 2026 se notificaron 2 171 casos de malaria, para un acumulado de 44 210 casos, de los cuales 43 704 son de malaria no complicada y 506 de malaria complicada. Predomina la infección por *Plasmodium vivax* con 70,0 % (30 949), seguido de *Plasmodium falciparum* con 28,9 % (12 779) e infección mixta con 1,1 % (482). No se han encontrado focos de *Plasmodium malariae*.

Malaria no complicada

Por procedencia, los departamentos que aportaron el 94,1 % de los casos de malaria no complicada fueron: Chocó (37,4 %), Antioquia (13,6 %), Córdoba (7,8 %), Nariño (5,7 %), Guainía (5,0 %), Risaralda (4,1 %), Amazonas (3,6 %), Cauca (3,4 %), Bolívar (3,2 %), Vichada (2,8 %), Meta (2,7 %), Buenaventura (2,6 %) y Vaupés (2,2 %). Por municipio, los que presentan la mayor carga de malaria no complicada y aportan el 71,6 % de los casos son los que se muestran en la tabla 20.

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Tabla 20. Casos notificados y tasa de incidencia de malaria no complicada por entidad territorial y municipio de procedencia, Colombia, semanas epidemiológicas 01 a 33 de 2026

Entidad territorial	Municipio	Acumulado	Casos SE 26 a 29 2026	Casos SE 30 a 33 2026	Tasa por 1 000 habitantes Riesgo malaria
Chocó	Quibdó	3048	568	570	20,46
Córdoba	Tierralta	2287	320	228	22,57
Guainía	Inírida	1973	159	132	49,84
Risaralda	Pueblo Rico	1637	228	172	97,36
Chocó	Lloró	1427	210	175	131,35
Chocó	Bagadó	1356	262	237	112,29
Antioquia	El Bagre	1201	141	154	21,06
Buenaventura	Buenaventura	1116	182	134	3,43
Chocó	Istmina	1083	156	116	30,98
Meta	Puerto Gaitán	944	132	75	19,99
Chocó	Medio San Juan	902	105	151	74,51
Vichada	Cumaribo	851	91	44	9,49
Vaupés	Mitú	798	81	81	21,80
Cauca	Timbiquí	775	142	58	27,05
Bolívar	Montecristo	765	107	100	41,10
Chocó	Alto Baudó	753	140	109	23,41
Chocó	Juradó	709	114	56	91,61
Chocó	Río Quito	707	89	90	74,93
Chocó	Carmen del Darién	673	142	158	29,58
Chocó	Tadó	639	104	156	30,78
Chocó	Bajo Baudó	629	106	148	18,00
Nariño	Olaya Herrera	606	52	81	22,66
Cauca	Guapi	605	94	54	20,09
Antioquia	Nechí	585	90	87	20,69
Chocó	El Cantón del San Pablo	577	108	53	80,89
Amazonas	Tarapacá (CD)	564	52	51	125,50
Norte de Santander	Tibú	562	88	107	8,97
Córdoba	Puerto Libertador	527	76	54	11,44
Antioquia	Cáceres	465	58	42	14,73
Chocó	Atrato	457	84	98	64,61
Amazonas	La Pedrera (CD)	433	28	46	99,45
Guaviare	San José del Guaviare	421	55	48	6,32
Antioquia	Chigorodó	405	47	62	6,42
Chocó	Medio Atrato	402	47	44	30,25
Nariño	El Charco	395	100	20	16,80

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026. SE: semana epidemiológica

Nota: en la tabla se muestran las entidades territoriales y los municipios que aportan el 71,6 % de los casos.

En cuanto a la distribución de casos de malaria por especie parasitaria se observa que para *P. vivax*, 15 municipios aportan el 47,7 %; en comparación con el período anterior, se evidencia un decremento en los municipios de Tierralta, Inírida, Pueblo Rico, Quibdó, Lloró, Bagadó, Puerto Gaitán, Mitú, Montecristo, Juradó y Cumaribo y un incremento en los municipios de El Bagre, Carmen del Darién y Tibú (tabla 21). Por *P. falciparum*, 15 municipios concentran el 63,8 %. En este grupo se evidencia un decremento en los municipios de Buenaventura, Timbiquí, Guapi, Istmina, Río Quito, El Charco, Medio Atrato y Alto Baudó y en incremento los municipios de Quibdó, Medio San Juan, Bagadó, Olaya Herrera, Inírida y Magüí como se muestra en la tabla 22.

Tabla 21. Casos de malaria no complicada por *P. vivax* por entidad territorial y municipio de procedencia, Colombia, a semana epidemiológica 01 a 33 de 2026

Entidad territorial	Municipio	Casos SE 26 a 29 de 2026	Casos SE 30 a 33 de 2026	Variación	% Aporte Nacional
Córdoba	Tierralta	296	213	-28%	6,6%
Guainía	Inírida	145	115	-21%	5,5%
Risaralda	Pueblo Rico	193	135	-30%	4,5%
Chocó	Quibdó	226	182	-19%	3,9%
Antioquia	El Bagre	136	150	10%	3,7%
Chocó	Lloró	126	92	-27%	3,0%
Chocó	Bagadó	155	125	-19%	2,8%
Meta	Puerto Gaitán	121	70	-42%	2,7%
Vaupés	Mitú	82	70	-15%	2,4%
Bolívar	Montecristo	110	100	-9%	2,4%
Chocó	Juradó	114	56	-51%	2,3%
Vichada	Cumaribo	74	28	-62%	2,1%
Chocó	Carmen del Darien	131	134	2%	2,0%
Antioquia	Nechí	89	87	-2%	1,9%
Norte de Santander	Tibú	88	109	24%	1,8%

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026
SE: semana epidemiológica

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Tabla 22. Casos de malaria no complicada por *P. falciparum* por entidad territorial y municipio de procedencia, Colombia, a semana epidemiológica 01 a 33 de 2026

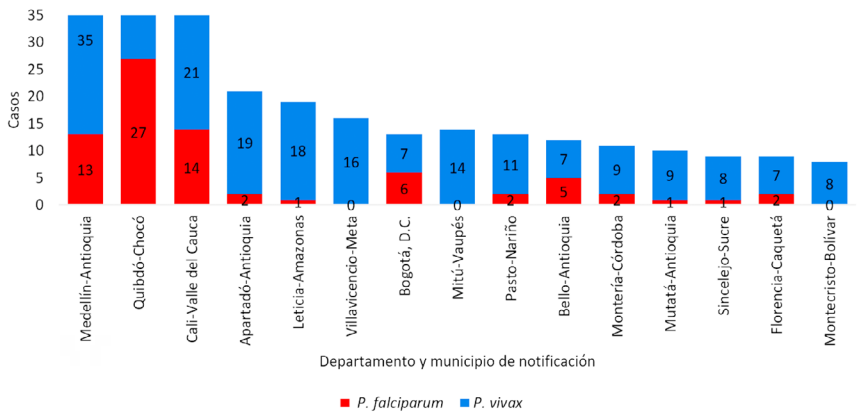
Entidad territorial	Municipio	Casos SE 26 a 29 de 2026	Casos SE 30 a 33 de 2026	Variación	% Aporte Nacional
Chocó	Quibdó	348	386	11%	14,6%
Buenaventura	Buenaventura	148	85	-43%	6,0%
Cauca	Timbiquí	142	57	-60%	6,0%
Cauca	Guapi	89	51	-43%	4,4%
Chocó	Istmina	77	55	-29%	4,3%
Chocó	Rio Quito	66	61	-8%	4,1%
Chocó	Lloró	82	80	-2%	3,6%
Chocó	Medio San Juan	62	83	34%	3,6%
Chocó	Bagadó	95	111	17%	3,5%
Nariño	El Charco	41	15	-63%	2,7%
Nariño	Olaya Herrera	27	45	67%	2,3%
Chocó	Alto Baudo	76	49	-36%	2,3%
Chocó	Medio Atrato	64	31	-52%	2,2%
Nariño	Magüi	23	41	78%	2,2%
Guainía	Inírida	14	16	14%	2,0%

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026. SE: semana epidemiológica

Malaria complicada

A la semana epidemiológica 33 de 2026 se han notificado 506 casos de malaria complicada, que son notificados por 32 entidades territoriales. Antioquia, Chocó, Amazonas, Nariño, Cali, Meta, Caldas, Vichada, Caquetá, Bogotá, Risaralda, Bolivar, Santander, Sucre, Vaupés y Córdoba y notificaron el 87,7 % de los casos; en la gráfica se muestran los municipios que aportan el 51,4 % de los casos de malaria complicada a nivel nacional (figura 19).

Figura 19. Distribución de casos de malaria complicada en los municipios de notificación con mayor carga, según especie parasitaria. Colombia, semana epidemiológica 33 de 2026



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026. SE: semana epidemiológica

Comportamientos inusuales en entidades territoriales

El análisis de comportamientos inusuales indica que, a la semana epidemiológica 33 del 2026 el país se encuentra dentro de lo esperado. Se encuentran 6 departamentos en situación de incremento y 8 departamentos en situación de decremento; a nivel municipal, se encuentran 43 municipios en incremento y 64 municipios en decremento (tabla 23).

Tabla 23. Departamentos y municipios en situación de incremento para malaria comportamientos inusuales, Colombia, semanas epidemiológicas 01 a 33 de 2026

Departamento	Municipio	Estrato de Riesgo	Acumulado 2025	SE 33 2025	Acumulado 2026	SE 33 2026	Esperado	Observado
Amazonas	Tarapacá (CD)	4	1047	17	574	10	47	52
Amazonas	El Encanto (CD)	4	4	3	160	2	0	6
Antioquia	Frontino	4	172	5	294	6	34	57
Antioquia	Puerto Berrío	4	10	0	12	2	1	4
Antioquia	Anorí	4	67	6	165	1	10	15
Antioquia	Cáceres	5	502	12	468	1	31	42
Antioquia	Remedios	4	82	5	75	3	7	12
Antioquia	Nechí	5	777	10	594	20	41	91
Antioquia	Yondó	4	47	0	60	1	0	3
Antioquia	Tarazá	4	400	6	177	12	24	43
Antioquia	Amalfi	4	12	0	14	0	0	3
Antioquia	Caucasia	4	293	4	180	2	10	29

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Departamento	Municipio	Estrato de Riesgo	Acumulado 2025	SE 33 2025	Acumulado 2026	SE 33 2026	Esperado	Observado
Bolívar	San Jacinto del Cauca	4	14	0	6	0	0	2
Bolívar	Río Viejo	4	15	0	113	4	7	13
Bolívar	Montecristo	5	726	20	776	20	63	101
Bolívar	Santa Rosa del Sur	4	58	4	84	1	7	21
Caquetá	San Vicente del Caguán	4	14	0	61	0	0	3
Caquetá	Cartagena del Chairá	4	5	0	31	1	2	7
Caquetá	Florencia	4	248	1	118	1	3	7
Chocó	El Carmen de Atrato	4	169	13	260	3	6	40
Chocó	El Cantón del San Pablo	5	714	7	577	0	43	53
Chocó	Condoto	4	150	1	235	7	18	44
Chocó	Medio San Juan	5	879	21	905	22	83	152
Chocó	Nóvita	5	249	12	389	25	31	125
Chocó	Belén de Bajirá	5	125	8	457	23	11	60
Chocó	Lloró	5	1399	49	1435	32	127	176
Chocó	Istmina	5	959	43	1095	20	74	118
Chocó	Unión Panamericana	5	165	4	198	2	18	32
Chocó	Juradó	4	260	12	709	17	27	56
Chocó	Río Quito	5	457	11	713	24	81	90
Chocó	Quibdó	5	2391	59	3107	141	428	579
Chocó	Carmen del Darién	5	662	16	677	35	66	158
Chocó	Atrato	5	247	6	460	14	58	98
Córdoba	Chinú	4	0	0	4	1	1	3
Guaviare	San José del Guaviare	5	477	13	426	5	42	52
Guaviare	Calamar	4	122	1	195	3	16	34
Guaviare	Miraflores	3	57	0	67	2	9	14
Meta	Puerto Rico	4	64	1	40	0	1	10
Meta	Puerto Gaitán	4	251	5	960	16	8	78
Meta	Villavicencio	4	41	0	36	0	1	7
Norte de Santander	Teorama	4	3	0	26	0	1	11
Norte de Santander	Convención	4	3	0	35	0	0	5
Norte de Santander	El Carmen	4	4	0	14	1	0	2

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026.
SE: semana epidemiológica

Desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años

Metodología

Se define un caso de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años de edad, cuando el puntaje Z del indicador peso/talla o longitud está por debajo de -2 DE, y/o presenta los fenotipos de la desnutrición aguda severa (marasmo, kwashiorkor o kwashiorkor marasmático). Está asociada a pérdida de peso reciente o incapacidad para ganarlo, de etiología primaria, dado en la mayoría de los casos por bajo consumo de alimentos o presencia de enfermedades infecciosas[1].

- **Desnutrición aguda moderada:** se determina cuando el puntaje Z del indicador peso para la talla o longitud está entre -2 y -3 DE, puede acompañarse de algún grado de emaciación o delgadez. Este tipo de desnutrición debe detectarse y tratarse con oportunidad, dado que en poco tiempo se puede pasar a desnutrición aguda severa y/o complicarse con enfermedades infecciosas.
- **Desnutrición aguda severa:** se determina cuando el puntaje Z del indicador peso para la talla o longitud está por debajo de –3 DE, o cuando se presenta edema bilateral que puede llegar a anasarca. La desnutrición aguda severa puede presentar fenotipos clínicos que son el kwashiorkor, marasmo y marasmo-kwashiorkor.

La prevalencia de desnutrición aguda en menores de cinco años se calcula utilizando como numerador los casos notificados que cumplen con la definición operativa; para el denominador se toma la población menor de 5 años de las proyecciones de población DANE 2025. Se incluyen en el análisis los casos residentes en el país.

Para el análisis de comportamientos inusuales, se usó la distribución de probabilidades de Poisson por medio de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento según su comportamiento medio entre el 2021 y 2025 con corte al periodo de tiempo por analizar, para aquellas entidades con un valor observado inferior a 30 casos; para aquellas entidades con un valor observado superior a 30, se utilizó la metodología de MMWR donde se establece una distribución de probabilidad a partir de la mediana del evento, teniendo en cuenta la variabilidad de las entidades territoriales con mayor incremento y decremento.

Los datos pueden variar semanalmente por la notificación tardía y ajuste de casos al Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

[1] Instituto Nacional de Salud, Colombia. Protocolo de vigilancia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años. Versión 8. 24 de abril de 2024. Disponible en: *https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/PRO_DNT%20Aguda%20en%20menores%20de%205%20a%C3%B1os%202024.pdf*

A semana epidemiológica 33 del 2026, se han notificado 13 737 casos de desnutrición en menores de cinco años, de los cuales 13 663 corresponden a residentes en Colombia y 74 casos de residentes en el exterior.

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

La prevalencia nacional preliminar acumulada de las últimas 52 semanas epidemiológicas (34 de 2025 a 33 de 2026) es de 0,53 casos por cada 100 menores de 5 años; las entidades territoriales con prevalencias acumuladas más altas corresponden a La Guajira, Chocó, Vichada, y Risaralda (tabla 24).

El 83,1 % de los casos fue clasificado como desnutrición aguda moderada, mientras que el 16,9 % como desnutrición aguda severa. Entre los niños y niñas mayores de seis meses, el 5,4 % presentó perímetro braquial inferior a 11,5 cm. La mayor proporción de casos de desnutrición aguda se reportó en menores de 1 año (28,1 %) y en los de 1 año de edad (27,0 %). Así mismo, el 66,1 % de los casos residen en las cabeceras municipales.

Para la semana epidemiológica 33 del 2026, se observaron diferencias significativas en la notificación en los departamentos de Guainía, Norte de Santander, San Andrés y Vaupés; el nivel nacional se encuentra en un comportamiento estable. La información puede ser consultada en las **tablas de mando del BES**.

Así mismo, se identificó un comportamiento inusual de incremento en 200 municipios a nivel nacional (17,8 %) y de disminución en 87 municipios (7,7 %). En el análisis de municipios con más de 100 000 habitantes, comparado con el promedio histórico 2021 2025, se registraron diferencias significativas en la notificación de 21 municipios (tabla 25).

Tabla 24. Casos de desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años y porcentaje de municipios con comportamiento inusual según entidad territorial de residencia, Colombia, a semana epidemiológica 33, 2025-2026

Entidad territorial de residencia	Casos a SE 33 de 2025	Casos a SE 33 de 2026	Prevalencia por 100 menores de 5 años (últimas 52 SE) *	% de municipios en aumento	% de municipios en disminución
Colombia	**13964**	**13663**	**0,53**	**17,8**	**7,7**
La Guajira	1087	1056	1,53	26,7	20,0
Chocó	562	607	1,30	25,8	16,1
Vichada	141	142	1,23	0,0	25,0
Risaralda	311	357	0,82	21,4	7,1
Guaviare	48	46	0,77	0,0	0,0
Cartagena de Indias	343	372	0,69	0,0	0,0
Arauca	124	123	0,68	0,0	28,6
Magdalena	552	410	0,67	13,8	10,3
Cesar	627	665	0,67	24,0	16,0
Boyacá	347	375	0,62	14,6	3,3
Casanare	177	159	0,56	5,3	26,3
Nariño	470	524	0,56	21,9	3,1
Antioquia	1889	1759	0,56	22,4	2,4
Vaupés	22	17	0,55	0,0	16,7
Bogotá, D.C	1792	1680	0,54	0,0	0,0
Bolívar	410	392	0,53	24,4	8,9
Norte Santander	451	383	0,52	7,5	7,5
Cundinamarca	775	793	0,51	12,9	6,0
Putumayo	132	127	0,49	15,4	15,4
Meta	261	303	0,48	24,1	13,8
Amazonas	49	32	0,47	9,1	9,1
Sucre	267	273	0,45	38,5	3,8
Valle del Cauca	430	404	0,44	37,5	5,0
Santiago de Cali	371	339	0,43	0,0	0,0
Guainía	29	20	0,41	0,0	11,1
Buenaventura	119	89	0,41	0,0	0,0
Huila	301	268	0,39	8,1	8,1
Santa Marta	120	113	0,39	0,0	0,0
Tolima	210	231	0,39	14,9	6,4
Córdoba	328	414	0,35	20,0	10,0
Caquetá	98	94	0,33	0,0	25,0
Caldas	123	124	0,32	14,8	0,0
Barranquilla	200	131	0,30	0,0	0,0
Archipiélago de San Andrés y Providencia	3	11	0,30	100,0	0,0
Santander	328	313	0,29	12,6	4,6
Atlántico	223	225	0,29	18,2	31,8
Quindío	55	64	0,28	8,3	8,3
Cauca	189	228	0,28	28,6	7,1

*SE: Semana Epidemiológica, *Casos acumulados de SE 34 de 2025 a SE 33 de 2026.*
Fuente: Sivigila. Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2025 y 2026 (Información preliminar); DANE, Proyecciones de población 2025.

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Tabla 25. Comportamiento inusual de la notificación de casos de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años a Sivigila, en municipios con más de 100 000 habitantes Colombia, a semana epidemiológica 33 del 2026

Departamento	Municipio	Valor esperado	Valor observado
La Guajira	Maicao	237	136
Risaralda	Dosquebradas	32	92
Cundinamarca	Fusagasugá	46	80
Sucre	Sincelejo	39	75
Tolima	Ibagué	44	74
Valle del Cauca	Tuluá	25	42
Antioquia	Rionegro	26	39
Cauca	Popayán	23	36
Cesar	Aguachica	20	36
Huila	Pitalito	24	34
Quindío	Armenia	38	29
Valle del Cauca	Cartago	17	29
Antioquia	Apartadó	45	26
Santander	Girón	37	25
Santander	Piedecuesta	32	22
Antioquia	Envigado	13	21
Cauca	Santander de Quilichao	15	20
Atlántico	Sabanalarga	28	18
Atlántico	Malambo	25	13
Norte de Santander	Villa del Rosario	36	11
Cundinamarca	Girardot	36	10

Fuente: Sivigila. Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2020 a 2025 (Información preliminar).

Para mayor información, consulte el tablero de control del evento de desnutrición aguda en menores de 5 años disponible en: ***http://url.ins.gov.co/489r9***

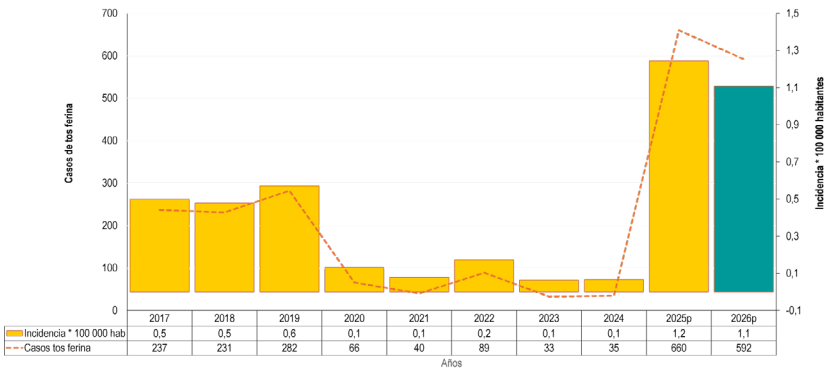
Comportamiento de la tos ferina en Colombia, hasta la semana epidemiológica 32 de 2026

Nota: el presente informe descriptivo se refiere exclusivamente al análisis de los casos confirmados de tos ferina, ya sea por laboratorio, nexo epidemiológico o criterio clínico. Las incidencias se calcularon únicamente con base en los casos procedentes de Colombia.

Hasta la semana epidemiológica 32 de 2026p, a nivel nacional se notificaron en Sivigila 3 643 casos probables de tos ferina; de estos, el 16,6 % (606) correspondió a casos confirmados (de los 606 casos confirmados, 592 correspondieron a casos con procedencia nacional y fueron utilizados para el cálculo de incidencia); el 76,3 % (2 780) correspondió a casos descartados y el 7,1 % (257) permanece en estudio.

La incidencia nacional de tos ferina registrada durante la semana epidemiológica 32 fue de 1,1 casos por cada 100 000 habitantes. Al comparar esta cifra con los registros históricos de la misma semana epidemiológica en años anteriores, se observa un aumento en la incidencia respecto a los años previos (2017 a 2024), donde la incidencia no superó 0,6 casos por cada 100 000 habitantes. El comportamiento observado en 2026p es inferior al registrado durante el mismo periodo de 2025, cuando se notificaron 660 casos confirmados (figura 20).

Figura 20. Incidencia de tos ferina en Colombia a semana epidemiológica 32, 2017 a 2026p



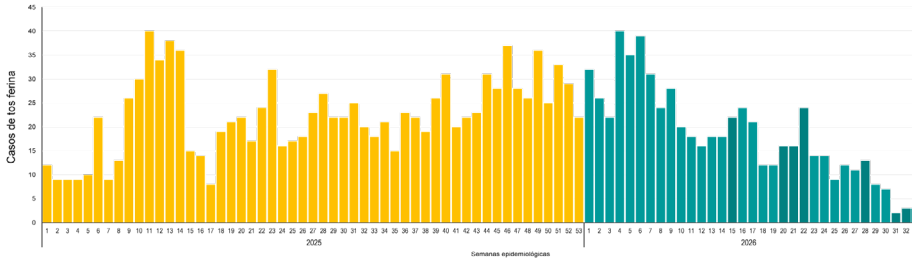
Fuente: Sivigila 2017 a 2026 p

p: dato preliminar sujeto a validación.

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

La figura 21 muestra el comportamiento semanal de los casos de tos ferina en Colombia durante 2025 (semanas epidemiológicas 01 a 53), evidenciando un incremento progresivo a partir de la semana epidemiológica 06, con un pico máximo en la semana epidemiológica 11 (40 casos). Posteriormente, se observa una disminución relativa de los casos. Sin embargo, se identifican repuntes en las semanas epidemiológicas 23 (32 casos), 28 (27 casos), 31 (25 casos), 36 (23 casos), 40 (31 casos), 44 (31 casos), 46 (37 casos), 49 (36 casos) de 2025 y 04 (40 casos), 06 (39 casos), 09 (25 casos) de 2026. En las últimas cuatro semanas se observó una reducción del 55,6 %, al pasar de 45 casos (semanas epidemiológicas 26 a 29 de 2026) a 20 casos (semanas epidemiológicas 30 a 32 de 2026). Se debe tener en cuenta que los datos están sujetos a ajuste debido al rezago en la notificación y confirmación de casos.

Figura 21. Casos confirmados semanales de tos ferina en Colombia, semanas epidemiológicas 01 a 53 de 2025p y 01 a 32 de 2026p



Fuente: Sivigila 2025 y 2026 p
p: dato preliminar sujeto a validación.

Comportamiento de la tos ferina por entidad territorial de procedencia en Colombia, a semana epidemiológica 32, de 2019 a 2026p

El mayor número de casos confirmados se registró en Antioquia (132 casos; incidencia: 1,9 por 100 000 habitantes), seguido de Bogotá, D.C. (59 casos; incidencia: 0,7 por 100 000 habitantes) y Santander (47 casos; incidencia: 1,9 por 100 000 habitantes).

La tabla 26 presenta el número de casos confirmados por entidad territorial de procedencia y su respectiva incidencia, en comparación con los datos históricos del período 2019-2026p para la misma semana epidemiológica.

Tabla 26. Incidencia de tos ferina por entidad territorial de procedencia, hasta la semana epidemiológica 32, 2019 a 2026p

	Incidencias por 100 000 habitantes									
Entidad territorial	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tendencia	2026
Colombia	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	1,2	1,1		592
Antioquia	0,7	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	2,2	1,9		132
Bogotá, D.C.	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,7		59
Santander	0,3	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	1,9		47
Cartagena de Indias	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,9		39
Boyacá	0,5	0,1	0,1	0,0	0,3	0,0	0,5	2,3		30
Cesar	0,3	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5	1,8		27
Cundinamarca	0,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	1,3	0,6		22
Casanare	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4		21
Norte de Santander	0,9	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	1,2		21
Chocó	0,2	0,2	2,6	0,2	0,0	0,3	2,4	3,0		18
Bolívar	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5		18
Santiago de Cali	0,1	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,5	0,8		18
Cauca	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9		14
Risaralda	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,1		11
Vaupés	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5		10
Barranquilla	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8		10
Arauca	1,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,7	3,2		9
Córdoba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,6	0,4		9
Caldas	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,9	0,8		8
La Guajira	0,0	0,1	0,0	5,9	0,0	0,0	0,8	0,7		8
Meta	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,9	0,6		7
Huila	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,3	1,9	0,6		7
Quindío	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,1		6
Magdalena	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,6		6
Atlántico	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4		6
Valle del Cauca	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3		6
Vichada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,6		4
Amazonas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5		3
Santa Marta	0,2	0,2	0,0	1,3	0,7	0,0	0,3	0,5		3
Sucre	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3		3
Nariño	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,2		3
Putumayo	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5		2
Tolima	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		2
Guaviare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2		1
Buenaventura	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,3		1
Caquetá	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,5	0,2		1

Fuente: Sivigila 2019 a 2026p
**La incidencia de Vaupés en 2019 corresponde a un brote registrado en población indígena de ese año.*

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Brotes de tos ferina identificados en población indígena por departamento de procedencia, Colombia, 2026p

En la semana epidemiológica 32 de 2026p se notificaron 159 casos confirmados de tos ferina en población indígena. El mayor número de casos asociados a brotes identificados en población indígena se registró en Cerrito (Santander), seguido de Dabeiba (Antioquia), Paz de Ariporo (Casanare) y Cubará (Boyacá).

La tabla 27 presenta los brotes actualmente identificados, junto con su distribución municipal y las fechas de inicio de síntomas y cierre.

Tabla 27. Brotes de tos ferina, Colombia, 2026p

Entidad Territorial	Municipio	Casos	FIS último caso	Fecha de cierre
Colombia		159		
Vaupés	Carurú	1	06/08/2026	17/09/2026
Boyacá	Cubará	10	20/07/2026	31/08/2026
Amazonas	Manapiare	1	13/07/2026	24/08/2026
Cauca	Toribío	7	04/07/2026	15/08/2026
Vaupés	Pacoa	1	26/06/2026	07/08/2026
La Guajira	Maicao	2	19/06/2026	31/07/2026
Boyacá	Güicán	7	16/06/2026	28/07/2026
Vaupés	Papunaua	2	16/06/2026	28/07/2026
Cesar	Agustín Codazzi	5	14/06/2026	26/07/2026
La Guajira	Uribia	1	11/06/2026	23/07/2026
Santander	Cerrito	23	10/06/2026	22/07/2026
Arauca	Saravena	1	10/06/2026	22/07/2026
Chocó	Riosucio	5	08/06/2026	20/07/2026
Cesar	Becerril	2	06/06/2026	18/07/2026
Antioquia	Murindó	4	06/06/2026	18/07/2026
Cesar	Valledupar	3	05/06/2026	17/07/2026
Vichada	Cumaribo	4	03/06/2026	15/07/2026
Norte de Santander	Toledo	2	26/05/2026	07/07/2026
Vaupés	Mitú	6	21/05/2026	02/07/2026
Antioquia	Betulia	1	12/05/2026	23/06/2026
Cauca	Caldono	4	08/05/2026	19/06/2026
Chocó	Litoral del Bajo de San Juan	1	27/04/2026	08/06/2026
Casanare	Hato de Corozal	2	23/04/2026	04/06/2026
Chocó	Tadó	2	20/04/2026	01/06/2026
Santander	Concepción	6	20/04/2026	01/06/2026
Chocó	Bagadó	1	20/04/2026	01/06/2026
Antioquia	Urrao	1	11/04/2026	23/05/2026
Casanare	Paz de Ariporo	13	01/04/2026	13/05/2026
Antioquia	Frontino	1	01/04/2026	13/05/2026
Antioquia	Dabeiba	16	28/03/2026	09/05/2026
Chocó	Carmen del Darién	4	10/03/2026	21/04/2026
Chocó	Lloró	1	08/03/2026	19/04/2026
Cauca	Santander de Quilichao	1	03/03/2026	14/04/2026
Caldas	Aranzazu	3	19/02/2026	02/04/2026
Norte de Santander	Chitagá	1	10/02/2026	24/03/2026
Norte de Santander	Cúcuta	3	08/02/2026	22/03/2026
Chocó	Belén de Bajirá	1	06/02/2026	20/03/2026
Cauca	Morales	2	27/01/2026	10/03/2026
Risaralda	Mistrató	1	27/01/2026	10/03/2026
Risaralda	Pueblo Rico	2	27/01/2026	10/03/2026
Chocó	Unguía	2	26/01/2026	09/03/2026
Putumayo	Orito	1	26/01/2026	09/03/2026
Boyacá	Puerto Boyacá	1	21/01/2026	04/03/2026
Risaralda	Balboa	1	12/01/2026	23/02/2026

FIS: fecha de inicio de síntomas
Celdas en gris: brotes de tos ferina que por tiempo ya cerraron
Fuente: Sivigila 2026p

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

BROTES, ALERTAS Y SITUACIONES DE EMERGENCIA EN SALUD PÚBLICA

ALERTAS NACIONALES

Sismo del 10 de agosto de 2026, Colombia, y acciones de vigilancia en salud pública. Actualización, corte 26 de agosto de 2026

El 10 de agosto de 2026, a las 07:34 horas, se presentó un sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El evento generó afectaciones principalmente en la región Pacífica y el Eje Cafetero, especialmente en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, y los distritos de Santiago de Cali y Buenaventura. Desde entonces, se mantiene activa la respuesta interinstitucional y el seguimiento por parte de las autoridades nacionales y territoriales. De acuerdo con el Reporte Situacional No. 049 (26 de agosto de 2026, 6:30 hora militar) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se registran afectaciones en 494 municipios de 16 departamentos.

En materia de vigilancia en salud pública, se mantienen en seguimiento ocho (8) brotes en el contexto de la emergencia posterior al sismo: un brote de infección asociada a la atención en salud (IAAS) por varicela zóster en Santiago de Cali; un brote de enfermedad diarreica aguda (EDA), con seis casos en el alojamiento temporal de emergencia (ATE) Coliseo Mayor de Manizales; un brote de parotiditis en el ATE Motel Tardes de París II, en Santiago de Cali; y cinco (5) brotes de enfermedad transmitida por alimentos (ETA), cuatro (4) en Risaralda y uno nuevo en el Albergue Escuela El Poblado de Quibdó, este último con 24 personas afectadas. En todos los eventos continúan las acciones de investigación epidemiológica, búsqueda activa, seguimiento de contactos, medidas de control y procesamiento de muestras. No se registran brotes activos ni alertas sanitarias asociados a enfermedades zoonóticas, transmitidas por vectores o infecciones de transmisión sexual (ITS). Continúa además el seguimiento de eventos no transmisibles priorizados, salud mental y determinantes sociales, incluida la violencia de género e intrafamiliar.

La emergencia mantiene una alta demanda sobre los ATE, con 109 ATE conformados y 99 caracterizados y activos, con un total de 4 551 personas caracterizadas. Valle del Cauca registra el mayor número de ATE conformados (32), seguido de Buenaventura (22), Chocó (17), Risaralda (13), Santiago de Cali (11), Quindío (9) y Caldas (5). En términos de población caracterizada, Santiago de Cali concentra el mayor número de personas (1 405), seguido de Risaralda (946), Valle del Cauca (520), Buenaventura (506), Chocó (466), Quindío (429) y Caldas (279). Se mantiene la necesidad de garantizar atención humanitaria,

vigilancia sanitaria y acceso continuo a servicios básicos para la población alojada.

Persisten riesgos sanitarios en los ATE relacionados con el acceso a agua segura, el manejo de residuos sólidos y la presencia de vectores, plagas y animales de interés sanitario. Se identifican 10 ATE sin abastecimiento de agua para consumo humano: siete (7) en Buenaventura, dos (2) en Santiago de Cali y uno (1) en Pereira. Asimismo, se reportan condiciones regulares o deficientes en la recolección de residuos y presencia principalmente de zancudos en 16 ATE y moscas en 13, además de roedores, larvas, murciélagos, serpientes y garrapatas, con mayor concentración y diversidad de hallazgos en Buenaventura. Estos resultados mantienen la necesidad de fortalecer la vigilancia sanitaria, el control integrado de vectores y plagas, el manejo adecuado de residuos y la eliminación de potenciales criaderos.

Como parte de la respuesta, se mantiene activo el Centro Operativo de Emergencias en Salud Pública (COE-SP), la Sala de Análisis del Riesgo (SAR) y las acciones de vigilancia epidemiológica, ambiental y comunitaria. Con corte al 26 de agosto, la Vigilancia Basada en Comunidad (VBC) registra 407 reportes comunitarios, principalmente en Quindío (135), Chocó (84), Caldas (76) y Risaralda (39). Desde el último corte ingresaron 84 nuevos reportes, concentrados en Quindío (Córdoba, Montenegro y Circasia) y Chocó (Lloró, Riosucio, Medio Baudó, Cértegui, Bojayá, Quibdó y San José del Palmar). Se mantiene además el seguimiento mediante las Salas de Análisis del Riesgo Ambiental (SARA) y la caracterización de ATE a través de EWARS y otras herramientas territoriales.

Persisten afectaciones en la capacidad de respuesta del sector salud y de la Red Nacional de Laboratorios, asociadas a daños de infraestructura y restricciones operativas. Los Laboratorios de Salud Pública de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó presentan diferentes niveles de afectación o limitación, por lo que se mantienen planes de contingencia, reubicación temporal de áreas críticas, articulación con otros laboratorios de la red y acompañamiento técnico del INS para garantizar la continuidad de la vigilancia por laboratorio y el procesamiento de muestras prioritarias. Continúan además las acciones de salud mental y apoyo psicosocial y el seguimiento de las gestantes afectadas y alojadas en ATE, con valoración médica, controles prenatales, traslados y entrega de medicamentos e insumos, sin reportes de eventos maternos graves ni fallecimientos asociados.

Por su parte, la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión mantiene el monitoreo permanente de las capacidades en los territorios afectados. Al 26 de agosto se reporta una disponibilidad de 5 781 unidades de glóbulos rojos, distribuidas en Valle del Cauca (3 041), Caldas (1 341), Quindío (702), Risaralda (509) y Chocó (188), sin alertas por desabastecimiento de sangre o hemocomponentes.

La respuesta continúa orientada al monitoreo intensificado de los Eventos de Interés en Salud Pública, la investigación epidemiológica de los brotes, la vigilancia sindrómica y sanitaria de los ATE, la identificación de riesgos ambientales y sanitarios, la caracterización de nuevos alojamientos mediante EWARS (*Early Warning, Alert and Response System*) y otras herramientas territoriales, y el acompañamiento técnico para garantizar la continuidad de los procesos de vigilancia, diagnóstico, referencia y contrarreferencia de muestras. Debido a la magnitud y extensión de las afectaciones y al nivel de riesgo estimado como muy alto, se mantiene activa la respuesta nacional y el seguimiento continuo de la situación mediante el COE-SP y la Sala de Análisis del Riesgo Ambiental (SARA) nacional.

Fuente: UNGRD, Reporte Situacional No. 050, 26 de agosto de 2026; Reportes de Situación (SITREP) de las entidades territoriales afectadas; INS. Información del Centro Operativo de Emergencias en Salud Pública (COE-SP), Sala de Análisis del Riesgo en Salud Pública, Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), Vigilancia Basada en Comunidad (VBC), herramienta EWARS y Red Nacional de Laboratorios, corte 26 de agosto de 2026.

Situación actual de fiebre amarilla nacional, 23 de agosto de 2026

En 2024, se confirmaron 23 casos de fiebre amarilla, con 13 fallecimientos (letalidad 56,5 %). En 2025 se confirmaron 125 casos procedentes de Colombia y tres (3) procedentes del exterior[1] con 46 fallecimientos (letalidad 36,8 %)[2].

Para el 2026, a corte del 23 de agosto (datos preliminares), se han notificado 1 135 casos probables, 58 confirmados por laboratorio, con fecha de inicio de síntomas entre el 04 de enero hasta el 08 de agosto de 2026, el 95,0 % procedente de Tolima, 3,44 % procedente de Cundinamarca y 1,56 % de Meta. Se han notificado 28 mortalidades, 27 confirmadas, uno (1) excluido de la letalidad porque su causa de fallecimiento no fue fiebre amarilla, para una letalidad de 46,5 % (27/58)[3].

[1] Se excluyen cinco (5) casos de mortalidad del cálculo de la letalidad, ya que su causa de fallecimiento no fue por fiebre amarilla.
[2] El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.
[3] Se excluye un (1) caso de mortalidad del cálculo de la letalidad, ya que su causa de fallecimiento no fue por fiebre amarilla.

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

En el acumulado de 2024 a 2026 (datos preliminares) se confirmaron 206 casos de fiebre amarilla, concentrados en once departamentos: Tolima, Meta, Cundinamarca, Putumayo, Caquetá, Nariño, Vaupés, Caldas, Cauca, Huila y Guaviare. Adicionalmente, se confirmaron tres (3) casos con procedencia del exterior (Venezuela). Con relación a las mortalidades acumuladas 2024 a 2026 (datos preliminares), se han confirmado 86 casos de mortalidades, seis (6) casos excluidos del cálculo de la letalidad, para una letalidad acumulada del 41,7 % (86/206).

Para 2026, datos preliminares, los casos confirmados de fiebre amarilla se presentaron en Tolima: Chaparral (21), Icononzo (8), Cunday (7), Ortega (5), Melgar (5), Carmen de Apicalá (2), Rioblanco (2), Purificación (2), Suarez (1), Dolores (1), Planadas (1). En Meta, un (1) caso de procedencia Villavicencio, y dos (2) casos en Cundinamarca del municipio de Paratebueno.

Durante el periodo comprendido entre el 18 y el 23 de agosto de 2026, no se han confirmado casos de fiebre amarilla en humanos.

Respecto a las epizootias, durante 2026 (datos preliminares) se han confirmado 31 casos de fiebre amarilla en primates no humanos (PNH). Los últimos casos se confirmaron el 21 de agosto de 2026 por el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud en zonas rurales de los municipios de Melgar y San Antonio.

Nota aclaratoria: semana epidemiológica 53 (28 de diciembre al 03 enero de 2026) y semana epidemiológica 01 (04 al 10 enero de 2026). Los casos de eventos transmitidos por vectores en la semana epidemiológica se calculan según fecha de inicio de síntomas.

Fuente: Sala de Análisis del Riesgo Nacional – INS. Instituto Nacional de Salud. Sistema de Alerta de Temprana.

Actualización de situación de sarampión a nivel nacional, 25 de agosto de 2026

Con corte al 25 de agosto de 2026, se han notificado 1 780 casos sospechosos de sarampión en el país, de estos, 1 607 han sido descartados, 159 casos permanecen en estudio en Bogotá, D.C. (75), Antioquia (52), Norte de Santander y Huila (3), Barranquilla, Caldas, Cesar, Nariño, San Andrés, Sucre, Tolima y Valle del Cauca (2), Atlántico, Boyacá, Cali, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Quindío, Risaralda y Santa Marta un caso cada uno. Se han confirmado 14 casos, de estos, ocho son importados y seis relacionados a la importación, no se han reportado complicaciones ni defunciones y se han cerrado ocho (8) brotes. En cuanto a la caracterización genética, seis (6) casos fueron genotipo D8. En respuesta a esta situación, se mantiene la activación del Centro de Operaciones de Emergencias en Salud Pública (COE-SP) y las Salas de Análisis del Riesgo (SAR) departamentales.

Fuente: Sala de Análisis del Riesgo, Instituto Nacional de Salud (INS), Colombia, 25 de agosto de 2026.

Actualización de la alerta naranja del volcán Puracé y acciones de vigilancia en salud pública, Cauca, 26 de agosto de 2026

Desde el 20 de julio de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene el seguimiento al incremento de la actividad del volcán Puracé, perteneciente a la cadena volcánica Los Coconucos (CVLC), departamento del Cauca. Tras la declaratoria de alerta naranja emitida el 01 de agosto de 2026, correspondiente a un estado de alistamiento institucional y preparación intersectorial, el boletín del 24 de agosto informó que persiste la actividad volcánica, con predominio de señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos y deformación lenta del suelo. Se registraron dos emisiones de ceniza, con reportes de caída en varias veredas del municipio de Puracé. Continúan las emisiones de dióxido de azufre (SO_2) y permanece el incremento de la concentración de dióxido de carbono (CO_2) en el suelo. Debido a la alteración de los parámetros monitoreados, se mantiene la alerta naranja.

Como parte de las acciones de preparación y respuesta, se mantienen habilitados cuatro Alojamientos Temporales de Emergencia (ATE) en Puracé, con capacidad conjunta para 870 personas y sin ocupación hasta la fecha. Se mantiene como línea base la identificación de 792 personas pertenecientes a 330 familias ubicadas en zona de amenaza alta del corregimiento de Puracé. Desde la Red de Vigilancia Comunitaria (REVCom) se mantiene la vigilancia intensificada ante caída de ceniza y posibles afectaciones de fuentes hídricas, acompañada de acciones de comunicación del riesgo, entrega de agua potable y distribución de tapabocas. Asimismo, continúa activo el Sistema Comando de Incidente y el fortalecimiento de las capacidades territoriales para la respuesta en salud. Entre las acciones pendientes se encuentran la actualización y emisión del concepto sanitario de los ATE de Coconuco y Paletará, la consolidación del censo oficial de la población ubicada en zonas de riesgo del corregimiento de Coconuco y la continuidad y ampliación de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de agua.

En la línea base de eventos de interés en salud pública priorizados para la semana epidemiológica 32 se identificó incremento de infección respiratoria aguda (IRA) en consulta externa y urgencias en Rosas y López de Micay; de enfermedad diarreica aguda (EDA) en Timbío, Sucre y Páez y de intoxicaciones en Sucre y Santander de Quilichao. La valoración del riesgo realizada por el Grupo de Factores de Riesgo Ambiental (GFRA) mediante la herramienta SATAES se mantiene en nivel bajo (verde), por lo que continúa el seguimiento permanente de la situación y de su evolución.

Fuente: Reporte de Situación (SITREP) del departamento del Cauca, 21 de agosto de 2026; Servicio Geológico Colombiano (SGC), boletín de actividad del volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos, 24 de agosto de 2026; Instituto Nacional de Salud. Sistema de Alerta Temprana (SAT), 20 de agosto de 2026.

Brote de morbilidad por enfermedad diarreica aguda (EDA), corregimiento de Caucheras, Mutatá (Antioquia), 20 de agosto de 2026

Se identificó un brote de enfermedad diarreica aguda en el corregimiento de Caucheras, municipio de Mutatá (Antioquia), asociado al incremento de consultas en el servicio de urgencias por síntomas gastrointestinales entre el 06 y el 14 de agosto de 2026. Se notificaron 46 casos de 379 personas expuestas, para una tasa de ataque del 12,1 %, con mayor ocurrencia el 11 de agosto (13 casos). El 45,6 % correspondió a menores de 12 años. Los casos se distribuyeron en los sectores Barrio Nuevo 17 (37,0 %), La Subestación 15 (32,6 %) y La Pista 14 (30,4 %).

La principal hipótesis corresponde a una posible exposición por consumo de agua sin tratamiento; sin embargo, hasta el momento no se ha identificado una fuente común de exposición. Entre los factores de riesgo identificados se encuentran el abastecimiento de agua sin procesos de potabilización, antecedentes de presencia de coliformes totales en el sistema de acueducto y actividades agrícolas en la zona de captación.

Como parte de la respuesta, se activó el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), se realizaron investigaciones epidemiológica y ambiental, búsqueda activa comunitaria, valoración médica de casos, educación sanitaria y acciones de comunicación del riesgo, relacionadas con el consumo seguro de agua, la manipulación de alimentos y las prácticas de higiene. Actualmente, se encuentran pendientes los resultados de las muestras de agua y se mantiene la investigación para establecer la fuente de exposición y fortalecer la vigilancia ante la aparición de nuevos casos.

Situación en seguimiento por el referente nacional y sujeta a cambios.

Fuente: Instituto Nacional de Salud. Sistema de Alerta de Temprana. Secretaría de Salud Departamental de Antioquia.

ALERTAS INTERNACIONALES

Situación epidemiológica sobre sarampión en Perú. Ministerio de Salud de Perú. Fecha de publicación: 20 de agosto de 2026

En el Perú, con corte a la semana epidemiológica 33 de 2026 se han confirmado 1 747 casos de sarampión. En Puno se reportó el 72,4 % de los casos, seguido por Arequipa con el 16,7 %, Cusco 2,9 %, Lima 2,7 % y Madre de Dios 2,7 %; el 2,6 % restante se reportó en Tacna, Moquegua, Loreto, Apurímac, Lambayeque, Huánuco, Cajamarca, Huancavelica, Áncash, Junín y Ucayali. Puno y Arequipa presentan transmisión comunitaria. En la semana epidemiológica 31 se notificó un brote nosocomial en personal asistencial de un hospital nacional; se reportaron cuatro (4) casos, el 75,0 % de sexo masculino, dos (2) contaban con una dosis documentada de sarampión-rubeola (SR) en 2018 y 2019, dos (2) reportan vacunación en la infancia no documentada. Los cuatro (4) casos fueron confirmados mediante RT-PCR para sarampión y no requirieron hospitalización; los casos presentaron vínculo epidemiológico con el establecimiento de salud. La investigación epidemiológica se encuentra en curso para establecer la fuente de infección.

Del total de casos confirmados, el 71,5 % (1 250 casos) fue captado en consultorio, lo que evidencia la frecuente interacción de personas infectadas con los servicios de salud y el consecuente riesgo de exposición del personal, otros pacientes, acompañantes y visitantes.

Fuente: Ministerio de Salud de Perú. ALERTA EPIDEMIOLÓGICA ANTE EL BROTE NOSOCOMIAL DE SARAMPIÓN. Fecha de publicación: 20 de agosto de 2026. Fecha de consulta: 24 de agosto de 2026. Disponible en: https://epipublic.dge.gob.pe/uploads/alertas/alertas_20268_21_204518.pdf

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

TABLA DE MANDO NACIONAL

Comportamiento de la notificación por entidad territorial a semana epidemiológica 33 de 2026

Los comportamientos inusuales permiten determinar el estado de un evento de interés en salud pública en las Entidades Territoriales, para esto, se utilizan varias metodologías estadísticas las cuales generan tres tipos de resultados que son presentados en las tablas anexas; el primero corresponde a las entidades con un aumento significativo en el número de casos y se representan en color amarillo, el segundo disminución significativa en el número de casos y se representan en color gris, y el tercero valores dentro de lo esperado en el número de casos y se representa en color blanco.

Comportamiento de la notificación por entidad territorial a semana epidemiológica 33

Decremento
Incremento

	Accidente ofídico			Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia			Dengue General (Dengue y Dengue Grave)			Dengue con signos de alarma			Dengue Grave			Hepatitis A			IRAG inusitado		
Tipo de casos incluidos para el análisis	Casos confirmados por clínica			Casos confirmados por clínica			Casos probables, Casos confirmados por laboratorio, y Casos confirmado por nexo epidemiológico			Casos probables, Casos confirmados por laboratorio, y Casos confirmados por nexo epidemiológico			Casos probables, Casos confirmados por laboratorio, y Casos confirmados por nexo epidemiológico			Casos confirmados por clínica, Casos confirmados por laboratorio y Casos confirmados por nexo epidemiológico			Casos probables y los criterios del evento		
Departamento	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado
Amazonas	36	1	4	362	33	39	580	20	81	87	6	17	1	0	1	1	0	0	1	0	0
Antioquia	380	13	9	14206	1391	1726	2633	300	378	983	124	141	27	4	5	198	66	5	60	7	3
Arauca	82	2	1	700	57	78	1994	127	348	619	32	101	24	1	4	1	1	0	23	3	1
Atlántico	58	4	0	2919	283	349	2389	186	435	1060	108	177	18	6	1	3	2	0	9	1	0
Barranquilla D.E.	7	0	1	3285	279	399	2227	137	298	1009	71	142	18	3	2	4	2	0	19	1	1
Bogotá D.C.	1	0	0	16220	1797	2019	25	0	0	5	0	0	0	0	0	63	18	18	2	0	0
Bolívar	179	7	2	1987	205	210	6293	301	1028	2568	149	450	88	7	7	3	1	0	4	0	1
Boyacá	57	1	2	4815	502	564	207	25	38	98	11	20	4	0	0	4	1	0	2	0	0
Buenaventura D.E.	14	0	0	94	11	6	99	29	10	32	12	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Caldas	49	1	1	2888	295	356	139	20	21	55	11	7	0	0	0	4	1	1	19	3	0
Santiago de Cali D.E.	8	0	0	3751	409	458	948	542	130	353	216	46	3	5	1	3	66	0	80	4	1
Caquetá	117	3	4	823	93	91	393	52	19	201	27	11	9	0	0	0	0	0	5	1	0
Cartagena de Indias D.T.	18	0	1	1770	142	225	2713	216	183	529	95	41	28	6	4	1	0	0	2	1	0
Casanare	105	2	7	1509	132	185	3054	123	625	917	49	197	19	2	3	1	2	0	6	2	1
Cauca	80	1	1	4240	452	411	153	52	34	52	19	10	4	1	3	4	4	1	12	1	0
Cesar	168	6	6	2138	201	268	5785	251	504	3270	160	285	42	6	9	1	1	0	25	3	1
Chocó	144	3	0	239	20	35	718	96	112	156	18	20	8	1	0	0	0	0	2	1	0
Córdoba	239	7	14	3672	387	394	2381	356	212	1021	176	109	10	4	0	1	1	0	3	0	0
Cundinamarca	65	1	2	10864	1074	1295	1158	135	185	433	66	71	10	1	2	10	4	1	6	0	1
Guainía	6	0	0	179	13	22	7	4	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Guaviare	54	2	0	265	62	44	858	27	407	167	7	59	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Huila	92	3	1	4788	377	523	928	177	175	344	72	57	40	6	4	7	1	0	27	1	1
La Guajira	92	5	3	1666	242	183	3035	108	78	1626	74	44	53	2	1	3	1	1	9	1	1
Magdalena	106	4	3	1697	183	168	4273	116	513	2139	80	247	30	2	3	1	3	0	4	0	0
Meta	188	5	5	3112	319	345	11911	395	1521	3545	141	436	107	4	12	7	11	0	17	3	1
Nariño	88	3	2	5370	536	631	537	64	88	214	21	26	5	1	0	2	1	0	8	1	0
Norte de Santander	230	5	4	5129	470	604	4622	311	800	1740	152	277	66	4	2	19	18	0	4	0	0
Putumayo	94	2	2	1348	131	154	316	58	70	86	16	20	5	0	0	0	0	0	4	0	0
Quindío	10	1	0	2351	231	262	272	24	48	71	9	22	5	0	1	1	1	1	3	1	0
Risaralda	46	0	0	3160	324	433	128	22	19	52	10	8	2	0	0	12	3	1	10	1	0
Archipiélago de San Andrés y Providencia	0	0	0	251	27	31	27	4	13	8	2	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0
Santa Marta D.T.	27	0	2	1399	133	181	2001	50	64	896	32	26	7	1	0	1	0	0	6	0	0
Santander	137	2	2	5833	534	692	4815	450	695	1850	198	290	33	6	8	63	4	6	6	0	0
Sucre	62	2	1	2015	193	221	1360	256	280	653	157	136	13	5	1	2	0	1	1	0	0
Tolima	103	2	1	5393	518	693	2151	348	365	686	150	145	29	4	4	4	3	2	16	1	1
Valle del Cauca	55	1	1	6526	628	765	1175	310	219	424	121	80	11	2	4	2	4	1	38	6	0
Vaupés	31	1	0	159	18	17	49	2	26	5	0	0	0	0	0	1	50	0	9	1	2
Vichada	35	2	2	162	23	15	77	21	12	23	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total nacional	3.263	92	84	127.285	12.724	15.092	72.431	5.715	10.035	27.979	2.599	3.728	723	84	83	429	271	39	442	44	16

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Comportamiento de la notificación por entidad territorial a semana epidemiológica 33

Decremento
Incremento

	Malaria			Meningitis bacteriana			Morbilidad por IRA consulta externa y urgencias			Morbilidad por IRA hospitalizaciones en sala general			Morbilidad por IRA hospitalizaciones en UCI			Morbilidad por EDA			Mortalidad perinatal y neonatal tardía		
Tipo de casos incluidos para el análisis	Casos confirmados por laboratorio			Casos sospechosos, Casos probables, Casos confirmados por laboratorio.			Notificación colectiva de atenciones en el servicio de consulta externa-urgencias			Notificación colectiva de atenciones en el servicio de hospitalización en salsa general			Notificación colectiva de atenciones en el servicio de hospitalización en UCI			Casos confirmados por clínica			Casos confirmados por clínica		
Departamento	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado
Amazonas	1609	202	130	2	8	1	3921	541	420	260	13	46	0	0	0	1881	378	196	11	13	11
Antioquia	6037	911	780	171	115	39	630282	75318	62836	24864	3151	2199	2550	803	504	259257	34457	33754	480	537	480
Arauca	159	7	14	6	7	2	15349	2652	2559	1864	186	426	43	6	14	5340	701	566	35	40	35
Atlántico	0	0	0	4	15	1	93065	13407	10209	2414	314	313	1520	261	217	38166	4608	4892	81	142	81
Barranquilla D.E.	0	0	0	14	25	3	134609	19616	14746	7405	521	939	888	290	215	49432	6222	5488	128	172	128
Bogotá D.C.	0	0	0	125	146	23	994223	136533	121628	47161	5767	4548	5979	1687	1305	478937	55353	62161	480	498	480
Bolívar	1421	115	180	18	18	2	85812	12074	8869	2102	263	208	286	88	60	20141	2788	1943	133	141	133
Boyacá	161	0	9	22	18	2	78917	12948	9248	4548	537	493	266	108	78	30961	3906	4106	70	89	70
Buenaventura D.E.	1128	189	137	11	5	2	6701	838	773	31	8	4	8	2	0	2093	494	197	37	50	37
Caldas	8	2	0	18	7	5	52836	7689	4600	2241	300	212	857	201	172	20650	2917	2256	54	63	54
Santiago de Cali D.E.	4	1	2	73	49	12	149840	20805	11482	4188	623	539	405	74	68	109248	12907	16247	160	188	160
Caquetá	266	9	19	16	11	4	21704	3488	1988	1594	178	140	18	8	8	10056	1587	954	33	42	33
Cartagena de Indias D.T.	2	0	0	13	14	3	109808	18208	12732	7835	439	982	1185	295	302	33247	4306	4026	96	148	96
Casanare	26	1	2	8	3	2	16781	3220	2448	283	85	31	100	18	21	7065	998	790	31	49	31
Cauca	1514	246	143	33	15	8	64112	10346	6055	3015	195	232	265	61	149	24075	5138	3115	127	155	127
Cesar	13	2	2	33	15	9	69419	11514	6837	3590	717	487	257	70	58	15952	3244	1625	145	171	145
Chocó	16512	2368	2646	14	11	0	16283	2138	1476	877	158	121	23	6	0	11405	958	1495	98	113	98
Córdoba	3429	888	352	18	17	8	131644	17687	14107	7048	629	626	1164	308	257	30342	4603	3240	168	240	168
Cundinamarca	0	0	0	54	33	10	222301	29693	24764	10481	1094	1227	693	327	158	104656	11696	12607	228	263	228
Guainía	2203	357	137	0	0	0	1159	247	141	69	22	11	0	0	0	1015	117	120	15	12	15
Guaviare	872	89	105	2	2	1	4146	668	767	729	44	124	49	6	18	2885	253	417	4	10	4
Huila	0	0	0	22	16	2	53144	11093	6473	3457	452	511	429	136	114	25270	4155	3133	104	115	104
La Guajira	12	1	2	7	8	1	175298	16013	21943	2486	519	220	430	60	31	27154	4344	3225	173	250	173
Magdalena	8	1	0	12	12	5	81569	9039	8960	2690	303	412	20	10	6	22923	3425	2660	73	122	73
Meta	1207	36	112	10	9	3	56422	8448	7305	2281	287	268	163	107	48	30169	3958	3153	90	116	90
Nariño	2528	813	277	53	35	13	74863	12390	7916	5204	433	650	124	61	27	30761	6117	4161	103	130	103
Norte de Santander	666	121	129	62	29	17	104250	12290	8485	7237	799	570	606	170	116	34833	5307	3936	111	145	111
Putumayo	58	4	4	6	7	1	26021	2621	3083	967	109	154	35	8	8	9441	1080	1158	22	39	22
Quindío	2	2	0	9	6	0	32742	5703	2628	1825	227	158	336	70	57	20722	2784	2304	38	38	38
Risaralda	1790	346	191	51	14	11	69875	9255	5345	2217	343	218	214	73	34	25739	3822	2396	68	67	68
Archipiélago de San Andrés y Providencia	0	0	0	1	1	0	3963	676	471	508	91	57	12	0	3	1603	289	246	2	8	2
Santa Marta D.T.	0	0	0	10	7	3	36927	5149	3426	2418	232	249	536	128	95	13189	1308	1427	53	59	53
Santander	14	1	2	84	34	20	165045	18874	16964	11322	1311	1246	1661	402	393	63280	6591	7146	107	146	107
Sucre	34	8	3	16	8	3	64358	8834	6951	4828	745	438	647	257	153	17573	3030	3057	91	119	91
Tolima	21	0	2	13	12	2	89025	12583	9253	6303	557	554	306	93	81	39682	5106	5290	68	96	68
Valle del Cauca	16	6	0	28	27	3	88966	12638	8575	2482	272	206	735	126	149	46116	6430	5639	108	130	108
Vaupés	956	212	309	7	3	3	4044	482	524	87	16	14	0	1	0	1817	111	176	5	9	5
Vichada	1237	100	56	2	3	0	1851	416	341	6	4	3	1	0	1	1064	177	140	27	24	27
Total nacional	43.914	7.152	5.520	1.048	765	224	4.031.275	546.134	437.328	188.917	21.944	19.836	22.811	6.313	4.920	1.668.140	215.663	209.442	3.857	4.750	3.857

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Comportamiento de la notificación por entidad territorial a semana epidemiológica 33

Decremento
Incremento

	Parálisis flácida aguda			Parotiditis			Síndrome de rubéola congénita			Tos ferina			Varicela			COVID-19		
Tipo de casos incluidos para el análisis	Casos sospechosos; Casos probables y Casos confirmados por laboratorio			Casos confirmados por clínica			Casos sospechosos			Casos probables, Casos confirmados por laboratorio; Casos confirmados por nexo epidemiológico			Casos confirmados por clínica, Casos confirmados por nexo epidemiológico			Casos confirmados por laboratorio		
Departamento	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado	Acumulado 2026	Esperado	Observado
Amazonas	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0	0	65	4	1	1	0	0
Antioquia	7	9	0	381	52	22	12	4	0	972	60	31	1785	208	205	261	45	48
Arauca	2	1	0	20	1	2	0	1	0	32	2	5	99	12	31	43	10	24
Atlántico	2	2	0	52	4	6	1	0	0	17	2	2	523	106	53	30	4	3
Barranquilla D.E.	1	2	0	117	9	14	0	0	0	40	4	2	675	73	65	70	16	6
Bogotá D.C.	14	9	0	966	117	102	555	4	14	899	85	48	3216	411	383	1201	330	256
Bolívar	6	3	0	28	2	0	2	0	0	26	3	3	297	41	20	15	1	1
Boyacá	3	2	0	107	15	13	12	1	0	115	5	16	483	67	52	140	41	39
Buenaventura D.E.	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	21	1	0	1	0	1
Caldas	2	1	0	28	7	5	2	0	0	20	2	0	314	32	23	11	2	2
Santiago de Cali D.E.	1	2	0	89	22	7	0	0	0	32	2	2	685	75	63	74	15	3
Caquetá	0	1	0	20	2	1	1	0	0	3	0	0	147	15	9	4	1	2
Cartagena de Indias D.T.	0	2	0	39	5	0	0	0	0	50	2	0	303	65	26	30	0	1
Casanare	2	1	0	35	2	3	0	0	0	45	0	0	154	19	14	10	4	4
Cauca	2	2	0	39	7	4	2	0	0	30	1	2	186	26	17	69	13	15
Cesar	1	3	0	57	4	2	0	0	0	66	3	3	462	30	24	17	5	1
Chocó	0	1	0	3	0	0	0	0	0	107	6	1	19	5	2	9	1	1
Córdoba	2	4	0	113	15	7	0	0	0	15	1	0	823	135	84	37	5	3
Cundinamarca	4	5	0	255	31	29	198	2	11	153	20	6	1578	170	201	209	56	41
Guainía	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	15	1	2	1	0	1
Guaviare	1	0	0	5	1	1	1	1	0	2	0	0	28	5	0	3	0	1
Huila	6	3	0	94	15	3	8	1	0	31	5	1	381	40	77	16	5	6
La Guajira	0	3	0	22	2	4	0	0	0	31	1	2	289	27	38	20	3	3
Magdalena	1	2	0	18	2	1	0	1	0	16	1	0	235	28	17	4	1	0
Meta	5	2	0	46	6	4	11	1	1	107	9	7	288	63	36	27	7	5
Nariño	7	3	0	85	13	11	2	1	1	59	6	3	522	54	63	21	3	3
Norte de Santander	3	2	0	118	15	9	0	0	0	97	5	2	1048	80	59	54	21	24
Putumayo	2	1	1	33	3	1	1	1	0	19	1	1	99	17	8	12	4	2
Quindío	0	1	0	39	5	1	1	1	0	19	2	0	225	22	19	30	5	3
Risaralda	1	1	0	33	5	0	1	1	0	78	2	0	331	45	23	15	2	2
Archipiélago de San Andrés y Providencia	0	0	0	4	0	0	0	1	0	3	0	0	53	2	4	1	0	0
Santa Marta D.T.	1	1	0	10	1	0	0	1	0	12	9	0	172	11	13	8	4	1
Santander	3	3	0	49	8	0	1	0	0	163	9	5	732	69	67	82	15	16
Sucre	2	2	0	36	5	5	3	1	0	27	12	1	327	55	31	28	5	1
Tolima	4	2	0	30	8	6	7	1	0	21	3	0	440	69	50	32	4	8
Valle del Cauca	3	3	0	99	12	6	1	0	0	12	1	1	700	90	55	26	6	7
Vaupés	0	0	0	3	0	0	1	1	0	101	3	6	15	0	0	3	0	1
Vichada	0	0	0	0	0	0	3	1	0	27	1	1	71	1	3	1	0	0
Total nacional	90	74	1	3.074	416	269	828	21	27	3.458	267	152	17.806	2.086	1.838	2.616	634	535

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Comportamiento de la notificación por entidad territorial a semana epidemiológica 33

Decremento
Incremento

	Chagas agudo		Chikunguña		Desnutrición aguda en menores de cinco años		Enfermedad por virus Zika		Intento de Suicidio		Leishmaniasis Cutanea	
Tipo de casos incluidos para el análisis	Casos confirmados por laboratorio y Casos confirmados por nexo epidemiológico		Casos confirmados por clínica y Casos confirmados por laboratorio		Casos confirmados por clínica		Casos sospechosos, Casos confirmados por clínica y Casos confirmados por laboratorio		Casos confirmados por clínica		Casos confirmados por laboratorio	
Departamento	Acumulado esperado	Acumulado 2026	Acumulado esperado	Acumulado 2026	Acumulado esperado	Acumulado 2026	Acumulado esperado	Acumulado 2026	Acumulado esperado	Acumulado 2026	Acumulado esperado	Acumulado 2026
Amazonas	0	0	0	0	41	32	0	0	51	61	10	7
Antioquia	1	1	0	1	1431	1759	1	1	3459	3745	747	433
Arauca	1	0	0	0	187	123	0	0	113	149	13	10
Atlántico	0	0	0	0	267	225	0	0	618	614	1	2
Barranquilla D.E.	0	0	0	0	162	131	0	0	602	616	0	0
Bogotá D.C.	1	0	0	0	2144	1680	0	0	3473	3929	0	0
Bolívar	0	2	0	0	327	392	0	0	374	345	278	256
Boyacá	2	0	0	0	333	375	0	0	681	616	126	74
Buenaventura D.E.	0	0	0	0	106	89	0	0	64	63	12	19
Caldas	0	0	0	0	123	124	0	0	771	793	137	69
Santiago de Cali D.E.	0	0	0	0	328	339	0	0	1115	1280	1	0
Caquetá	0	0	0	0	127	94	0	0	161	135	177	106
Cartagena de Indias D.T.	0	0	0	0	236	372	0	0	370	393	1	1
Casanare	6	0	0	0	220	159	0	0	193	186	5	5
Cauca	0	0	0	0	207	228	0	0	554	571	37	18
Cesar	3	0	0	0	522	665	0	0	382	389	138	232
Chocó	0	0	0	0	585	607	0	0	80	121	167	132
Córdoba	1	2	0	0	380	414	0	0	685	730	132	88
Cundinamarca	1	0	0	0	866	793	0	0	1503	1864	131	67
Guainía	0	0	0	0	37	20	0	0	19	18	12	8
Guaviare	0	0	0	0	67	46	0	0	38	45	208	107
Huila	0	0	0	0	297	268	0	1	535	544	6	10
La Guajira	0	0	0	0	1293	1056	0	0	199	231	18	23
Magdalena	0	0	0	0	425	410	0	0	247	256	5	7
Meta	1	0	0	0	289	303	0	0	459	411	130	71
Nariño	0	0	0	0	462	524	0	0	953	950	157	78
Norte de Santander	1	1	0	0	467	383	0	0	727	809	152	97
Putumayo	0	0	0	0	133	127	0	0	204	169	177	36
Quindío	0	0	0	0	70	64	0	0	331	326	0	0
Risaralda	0	0	0	0	284	357	0	0	793	778	0	0
Archipiélago de San Andrés y Providencia	0	0	0	0	7	11	0	0	19	22	72	49
Santa Marta D.T.	0	0	0	0	80	113	0	0	190	214	9	9
Santander	3	0	0	0	321	313	0	0	1069	1130	458	600
Sucre	1	0	0	0	188	273	0	0	320	294	71	62
Tolima	1	0	0	1	233	231	0	0	768	730	157	66
Valle del Cauca	0	0	0	0	331	404	1	0	855	928	12	5
Vaupés	0	0	0	0	41	17	0	0	53	53	29	8
Vichada	0	0	0	0	192	142	0	0	16	24	23	25
Total nacional	25	6	0	2	13.811	13.663	1	2	23.043	24.532	3.669	2.780

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Comportamiento de la notificación por entidad territorial a semana epidemiológica 33

Decremento
Incremento

	Leptospirosis		Mortalidad materna		Mortalidad por EDA en menores de 5 años		Mortalidad por IRA en menores de 5 años		Mortalidad por DNT aguda en menores de cinco años		Sarampión/Rubéola	
Tipo de casos incluidos para el análisis	Casos confirmados por laboratorio y Casos confirmados por nexo epidemiológico		Casos confirmados por clínica		Casos probables, Casos confirmados por clínica y Casos confirmados por laboratorio		Casos probables, Casos confirmados por clínica y Casos confirmados por laboratorio		Casos probables y Casos confirmados por clínica		Casos sospechosos	
Departamento	Acumulado esperado	Acumulado 2026	Acumulado esperado	Acumulado 2026	Acumulado esperado	Acumulado 2026	Acumulado esperado	Acumulado 2026	Acumulado esperado	Acumulado 2026	Acumulado esperado	Acumulado 2026
Amazonas	1	0	0	0	1	0	3	1	0	0	1	1
Antioquia	13	6	14	11	5	3	18	23	8	7	88	352
Arauca	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0	4	1
Atlántico	1	0	5	0	1	0	2	3	4	0	20	23
Barranquilla D.E.	4	2	4	0	1	1	4	5	2	1	16	19
Bogotá D.C.	1	0	12	11	0	1	28	23	0	0	101	766
Bolívar	2	0	6	1	1	1	5	10	4	3	16	5
Boyacá	0	2	3	2	1	0	4	3	1	0	16	17
Buenaventura D.E.	1	0	2	1	0	2	2	2	2	2	4	3
Caldas	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	13	10
Santiago de Cali D.E.	2	2	4	1	1	0	5	1	1	1	29	34
Caquetá	4	0	2	3	0	0	5	1	2	0	5	5
Cartagena de Indias D.T.	3	1	4	4	1	0	5	6	1	0	13	29
Casanare	1	0	1	2	1	0	1	3	1	0	6	7
Cauca	1	0	6	3	3	2	8	4	0	2	20	2
Cesar	1	0	8	4	4	3	5	9	9	8	19	23
Chocó	2	1	8	6	16	9	25	27	26	19	8	11
Córdoba	1	0	6	1	1	1	8	9	5	1	26	26
Cundinamarca	1	1	7	5	0	0	8	6	0	0	46	109
Guainía	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	1
Guaviare	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Huila	7	0	3	2	0	1	4	2	2	0	16	36
La Guajira	1	1	12	7	19	11	25	17	31	17	14	2
Magdalena	1	0	5	5	1	4	7	3	9	2	12	5
Meta	0	3	3	1	1	1	5	6	5	2	15	24
Nariño	1	1	7	4	1	2	7	5	2	0	22	25
Norte de Santander	0	0	5	0	1	0	3	3	3	0	22	43
Putumayo	0	1	1	0	0	2	2	0	1	1	5	7
Quindío	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	7	12
Risaralda	6	0	3	3	7	2	6	9	5	1	13	11
Archipiélago de San Andrés y Providencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Santa Marta D.T.	1	0	3	1	1	1	2	0	0	1	7	17
Santander	2	0	3	0	0	1	5	3	1	0	31	34
Sucre	1	1	2	2	0	1	4	1	2	0	13	13
Tolima	5	9	4	3	1	2	6	4	1	1	18	30
Valle del Cauca	2	0	2	1	1	2	7	3	3	1	27	50
Vaupés	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	1	0
Vichada	0	0	2	1	1	2	2	2	8	6	2	0
Total nacional	334	269	146	87	83	58	242	195	149	76	679	1.757

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Comportamiento de la notificación por entidad territorial a semana epidemiológica 33

Decremento
Incremento

	Sífilis congénita		Sífilis gestacional		Tétanos accidental		Tuberculosis		Tuberculosis farmacorresistente		Violencia de género e intrafamiliar	
Tipo de casos incluidos para el análisis	Casos confirmados por laboratorio, Casos confirmados por nexo epidemiológico y Casos confirmados por clínica		Casos confirmados por laboratorio, Casos confirmados por nexo epidemiológico y Casos confirmados por clínica		Casos probables y Casos confirmados por clínica		Casos confirmados por clínica, Casos confirmados por laboratorio y Casos confirmados por nexo epidemiológico		Casos confirmados por clínica, Casos confirmados por laboratorio y Casos confirmados por nexo epidemiológico		Casos sospechosos	
Departamento	Acumulado esperado	Acumulado 2026	Acumulado esperado	Acumulado 2026	Acumulado esperado	Acumulado 2026	Acumulado esperado	Acumulado 2026	Acumulado esperado	Acumulado 2026	Acumulado esperado	Acumulado 2026
Amazonas	2	2	13	16	0	0	39	48	1	2	417	353
Antioquia	102	85	794	961	1	1	2436	3176	78	89	14808	11433
Arauca	22	10	113	100	0	0	92	94	1	1	802	916
Atlántico	28	16	231	220	1	0	319	418	13	18	1636	1580
Barranquilla D.E.	29	16	258	234	1	2	557	633	16	27	1651	1945
Bogotá D.C.	76	73	567	663	0	0	853	974	23	26	20382	19828
Bolívar	30	15	201	193	1	3	133	144	3	2	1540	1586
Boyacá	16	6	67	59	0	1	117	145	2	2	2837	2774
Buenaventura D.E.	15	10	97	88	0	0	112	137	4	6	234	189
Caldas	13	8	89	102	0	0	215	213	3	4	2007	2173
Santiago de Cali D.E.	18	22	302	434	0	0	985	950	33	31	4891	4027
Caquetá	6	4	55	57	0	0	170	194	4	7	712	648
Cartagena de Indias D.T.	46	25	230	283	0	1	290	367	3	7	959	1232
Casanare	29	17	94	116	0	0	105	135	4	4	570	728
Cauca	15	8	120	147	0	0	199	184	2	1	2182	2175
Cesar	28	19	214	192	1	0	295	325	3	8	1304	1426
Chocó	33	23	162	142	0	0	152	165	2	0	287	341
Córdoba	18	15	199	182	2	0	187	205	4	2	2234	2251
Cundinamarca	43	27	257	319	0	0	351	437	9	11	9156	9829
Guainía	5	6	13	10	0	0	15	15	0	0	137	131
Guaviare	3	2	17	12	0	0	25	36	1	0	200	289
Huila	11	11	101	126	0	1	289	309	5	5	3984	4175
La Guajira	43	26	253	206	0	0	363	523	5	8	904	977
Magdalena	21	9	154	162	1	0	120	138	2	5	917	920
Meta	34	57	163	215	0	0	441	480	15	18	1621	1735
Nariño	10	10	148	155	0	1	123	183	4	6	2933	3284
Norte de Santander	60	23	322	298	0	0	486	619	10	11	2522	2776
Putumayo	3	5	63	60	0	1	73	84	3	0	907	1114
Quindío	7	7	63	62	0	0	185	207	3	5	1722	1622
Risaralda	19	9	118	125	0	1	416	476	14	7	2376	2349
Archipiélago de San Andrés y Providencia	1	0	5	6	0	0	7	12	0	1	155	158
Santa Marta D.T.	13	8	85	142	0	0	179	218	3	1	449	409
Santander	43	18	282	305	0	0	729	920	18	13	4114	4548
Sucre	11	8	136	116	0	2	69	66	0	2	1176	1182
Tolima	14	19	105	131	0	1	378	494	10	11	2076	2246
Valle del Cauca	24	17	212	278	0	0	484	692	14	16	4703	4717
Vaupés	1	2	3	5	0	0	14	15	0	0	187	291
Vichada	5	5	25	27	0	0	22	18	0	0	164	169
Total nacional	907	643	6.331	6.949	8	15	12.027	14.449	315	357	99.860	98.526

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).
* El número de casos puede variar después de realizar unidades, análisis, ajustes y clasificación del caso en cada evento desde las entidades territoriales.

Salud

Instituto Nacional de Salud

Semana epidemiológica 33

16 al 22 de agosto de 2026

TEMA CENTRAL
Comportamiento epidemiológico de dengue y enfermedad por virus Zika

Directora General INS
Dra. Zulma Milena Cucunubá Pérez

Expertos temáticos
Claudia Marcella Huguett Aragón
Directora (E) de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública

Greace Alejandra Ávila Mellizo
Subdirectora de Vigilancia, Control y Prevención

Luis Carlos Gómez Ortega
Subdirectora de Análisis del Riesgo y Respuesta Inmediata en Salud Pública

Una publicación del:
Instituto Nacional de Salud
Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública

Consulte el historial de publicaciones del BES

Conozca más en www.ins.gov.co

BES
Boletín Epidemiológico Semanal

Boletín Epidemiológico Semanal

Autores: tema central: Andrea Jineth Rodríguez Reyes, Adriana Díaz Bello, Lissethe Carolina Pardo Herrera, José Leonardo Gómez Gómez. **Situación nacional:** Verónica Tangarife Arredondo, Jennifer Andrea Méndez Romero, Gina Paola Flórez Piñeros, Yanuby Salgado Sánchez, Claudia Marcella Huguett Aragón. **Mortalidad:** Héctor Eduardo Pachón Melo, Gerhard Misael Acero de la Parra, Ana María García Bedoya, Viviana Inés Pantoja Muñoz. **Eventos trazadores:** Diana Marcela Forero Ombita, Andrea Jineth Rodríguez Reyes, Jessica María Pedraza Calderón, María Camila Giraldo Vargas, Ximena Castro Martínez, Angélica María Rico Turca. **Brotes y alertas: Gestor sistema de alerta temprana,** Aydee Devia Gamboa, Angie Paola Zabaleta, Claudia Marcela Montaño Fuertes, Eliana Mendoza Niño, Nieves Johana Agudelo Chivata, William León Quevedo, Yenny Marcela Elizalde, Andrea Rico Hernández. **Tablas de mando:** Gina Paola Flórez Piñeros, Eliana Mendoza, Claudia Marcella Huguett Aragón. **Editor:** Luis Carlos Gómez Ortega. **Corrector de estilo:** María Fernanda Campos Maya. **Diseño y diagramación:** Wilbert Saul Daza Criollo.

Bogotá, D.C., Colombia, Instituto Nacional de Salud-INS, Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública; publicación en línea/2026.

50 páginas; texto, ilustraciones, tablas.

ISSN 2357-6189

DOI: *https://doi.org/10.33610/23576189.2026.33*